FORMULARIO N°5

PRESENTACIÓN DE OFERTA FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Razón Social	
RUT	
Teléfono de contacto	
e-mail de contacto	
Solución	

COMPLETITUD DE OFERTA: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

NOTA: Los ítems catalogados como Exigible son de carácter obligatorio, el no incluirlos en la oferta será causal de **INADMISIBILIDAD** según lo establecido en las bases.
Los ítems catalogados como **Necesario** se asignara puntaje en la evaluación según las bases de licitación.

1 Requerimientos Generales

Requerimientos generales al HIS: Las siguientes funcionalidades tienen que estar disponibles de forma transversal para los procesos del sistema de información hospitalaria, para los diferentes perfiles de usuarios que lo requieran, se necesitan requerimientos que deben ser utilizadas por las distintas áreas, servicios, unidades y a nivel de usuario. A continuación, se presentan los requisitos que la solución debe permitir.

1.1 Administración de Usuarios

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RG01	**Gestion de cuentas de usuarios y grupos**: Administración de cuentas de usuario y asignación de grupos de seguridad o perfiles de acceso, operaciones de creación y caducidad estarán a cargo del Hospital Provincial de Ovalle y del Servicio Salud Coquimbo.	Exigible	N/A		
RG02	**Niveles de acceso**: Permite distintos niveles de acceso de perfiles diferenciados a las funciones de los usuarios, mediante claves encriptadas y al menos 3 niveles.	Exigible	N/A		
RG03	**Niveles de seguridad:** Debe resguardar la confidencialidad de los datos del paciente, cumpliendo con las normas y leyes sobre confidencialidad de datos sensibles, Ley 19.628 de Protección	Exigible	N/A		

	de Datos de Carácter Personal, así como también, con la ley de documentos y firma electrónica, y primordialmente al resguardo que merece la información clínica de un paciente durante un periodo de 15 años, si se dictaran leyes específicas que así lo determinen a futuro.				
RG04	**Selección de preferencia:** Permitir generar indicaciones favoritas, listado de indicaciones, mezclas preconfiguradas y diagnósticos recurrentes los cuales deben ser asociadas a cada perfil de usuario en caso de ser clínicos.	Exigible	N/A		

1.2 Mantenedores del Sistema con Permisos Administrativos

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RM01	**Administración de usuarios:** El sistema permite crear, modificar e inactivar perfiles de usuarios, asignación de privilegios, tiene que contar con un módulo de administración para la gestión de estas acciones	Exigible	N/A		
RM02	**Gestión de prestaciones:** Permitir la creación, edición y/o inactivación de prestaciones FONASA codificadas y no codificadas.	Exigible	N/A		
RM03	**Estructura de prestaciones:** Tiene que presentar diferentes niveles (vertical y horizontal) para diferenciar beneficios e identificar actividades o servicios que ofrecen las instituciones y que forman parte de la cartera principal, así como aquellas prestaciones que permitan modificaciones a través del tiempo**.**	Exigible	N/A		

1.3 Datos Demográficos del Paciente

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RD01	**Ingreso de datos de paciente a la plataforma:** La solución debe contemplar la utilización del registro de CMBD (conjunto mínimo básico de datos) definidos entre el Minsal y el hospital, permitiendo autocompletar los datos personales, previsionales de forma automática y actualizada, así como también otros datos disponibles de fuente propia, según lo exigido en la normativa vigente norma técnica N°820 (estándares de información de salud) o protocolos locales. Los datos deben ser: Identificación de la persona, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, estado civil, previsión de salud, otros seguros asociados, domicilio, teléfono y/o correo electrónico, ocupación, representante legal si aplica o apoderado para fines de atención de salud, sistema de salud al que pertenezca, nivel de escolaridad, religión, datos del grupo familiar, Etnia (campo obligatorio), nombre social, entre otros.	Exigible	N/A		
RD02	**Búsqueda de pacientes y datos:** Opciones de búsqueda rápida e intuitiva a través de distintos parámetros que identifiquen al paciente: RUN, Número de Pasaporte, Nombres, Apellidos, Número de Ficha Clínica, nombre social, entre otros.	Exigible	N/A		
RD03	**Datos del Paciente**: El Sistema debe administrar las operaciones de registrar, consultar, modificar e inactivar para los datos vinculados apacientes, conservando los registros de los datos involucrados, exceptuando la eliminación de datos.	Exigible	N/A		
RD04	**Registro recién nacido:** La generación del registro Clínico electrónico para el paciente recién nacido tiene que permitir el registro de antecedentes clínicos y administrativos correspondientes a su atención (Ejemplo: Vacunas, Prestaciones y Estados).	Exigible	N/A		
RD05	**Registro recién nacido:** Durante el proceso de parto y postparto inmediato se debe generar un RCE del recién nacido asociado al episodio materno.	Necesario	7		

	En caso de que la hospitalización sea sólo del recién nacido, se debe considerar un registro clínico individualizado para la madre e hijo en caso de complicaciones. Incorporando ficha de recién nacido, Ficha historia clínica perinatal, entre otros definidos por el hospital.				
RD06	**Registro paciente ficha clínica:** En caso de que el paciente no tenga un número de ficha clínica en el sistema y cuente con una apertura de registro clínico electrónico o episodio, el sistema debe generar un número de ficha clínica única.	Exigible	N/A		
RD07	**Registro:** Permite el registro e identificación de inmigrantes con su DNI del país o número de pasaporte, y posteriormente el ingreso de su RUN provisorio y/o definitivo.	Exigible	N/A		
RD08	**Datos del paciente en la plataforma de registro:** Permite la restricción de la modificación de datos del paciente nombres, apellidos, RUN, ID, Pasaporte, fecha nacimiento, sexo, a perfiles restringidos o limitados.	Exigible	N/A		
RD09	**Registro biométrico:** El sistema debe permitir registrar a los pacientes, mediante un lector biométrico para garantizar la identificación única del paciente con su correspondiente número de ficha clínica, RUN, DNI y pasaporte. El proceso de registro se llevará a cabo en las admisiones que el hospital estime pertinente.	Necesario	7		

1.4 Gestión de Agenda y Admisión (Estructura Agenda)

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RA01	**Creación de agenda:** El sistema permite a los usuarios autorizados, la creación de la estructura de agenda definiendo agenda diaria, semanal, mensual, la asignación de sus correspondientes bloques de horario y rendimiento por atención. Permitir asociación de un profesional clínico, servicio clínico y/o unidad, espacio físico.	Exigible	N/A		
RA02	**Visualización de estructura:** Representación gráfica de la distribución de salas de procedimiento y box de atención, mostrando el estado de disponibilidad para la asignación del paciente.	Exigible	N/A		
RA03	**Agenda:** Permite el bloqueo y desbloqueo de cupos de agenda, por días calendario u horas, permitiendo registrar y especificar los motivos de bloqueo ejemplo: pabellón en mantención, capacitaciones, licencias médicas, permisos, turnos, feriado legal, entre otros.	Exigible	N/A		
RA04	**Prestaciones:** Permite crear, modificar e inactivar tipos de prestaciones, sesiones o bloques de agendamiento en una agenda permitiendo que se ajuste a una demanda real.	Exigible	N/A		
RA05	**Agenda:** Permite visualizar los cupos disponibles de la agenda de un recurso para agilizar la asignación de una cita de un paciente.	Exigible	N/A		
RA06	**Agendamiento de cita:** Permitir la creación de citas asociando a un paciente con el respectivo profesional y sus correspondientes tipos de atención en relación con las prestaciones, visualización de las agendas creadas y cupos disponibles. El software tiene que registrar los diferentes estados de las citas insertando la fecha/hora, y el usuario que ejecutó el cambio de estado de la cita.	Exigible	N/A		
RA07	**Prestaciones:** Permite crear, modificar e inactivar tipos de prestaciones con códigos MAI y Códigos CIE-9 de procedimientos de acuerdo con la norma vigente.	Exigible	N/A		

RA08	**Agendamiento por tipos de atención:** El sistema tiene que permitir registrar consulta nueva y consulta repetida o control, relacionado a la atención a realizar, por ejemplo: Ingreso a programa, consulta abreviada, procedimientos y exámenes, entre otros.	Exigible	N/A		
RA09	**Agenda:** Permite el sobrecupo en agendas, cuando exista un aumento de citas en situaciones puntuales de demanda y compensaciones de bloqueos transitorios o de autorización del profesional.	Exigible	N/A		
RA10	**Transferencia de agenda de pacientes:** Permitir la selección del o los pacientes para ejecutar una transferencia masiva de pacientes agendados a otro profesional, conservando los bloques fecha y hora registradas, los pacientes transferidos tiene que ser identificados que provienen de una agenda anterior para la confirmación de asistencia.	Necesario	7		
RA11	**Lista de pacientes con citas canceladas:** El sistema debe permitir visualizar los pacientes que tienen citas canceladas y que no tienen asociada una nueva cita. La posibilidad de imprimir y/o exportar a formato PDF. Reporte de pacientes en estado de espera de citas sin reasignación en formato de ofimática homologable a office, tiene que incorporar los siguientes campos: RUN, nombre completo, tipo de atención y prestación asociado, teléfono, email entre otros.	Necesario	7		
RA12	**Control solapamiento agenda:** Emitir una alerta a la hora de la creación de agenda para el mismo profesional o recurso en caso de que el sistema detecte un registro ya existente con los mismos bloques de horario con fecha y hora.	Exigible	N/A		
RA13	**Visualización:** Modulo para visualizar resúmenes por profesional y especialidad, en relación con número y tipos de cupos o prestaciones.	Exigible	N/A		
RA14	**Consulta histórica:** Poseer sistema de consulta histórico por paciente o profesional que muestra todas las citas del paciente, en un periodo determinado, mostrando: fecha/hora, especialidad, profesional, asistencias e inasistencias y motivos de baja, lo que permitirá al personal del establecimiento disponer de diversos	Exigible	N/A		

	indicadores y predictores de tendencias.				
RA15	**Auditoria:** Permite identificar qué mantenedor de agenda o funcionario realizó la estructura, como sus modificaciones y/o el bloqueo de una agenda de acuerdo con registro de perfil.	Necesario	4		

1.5 Admisión – Citas

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RAA01	**Datos del paciente:** Permite autocompletar y presentar en forma claramente visible los datos de la persona seleccionada, o desde la búsqueda realizada, de modo de facilitar la comprobación de su identidad para los fines que el usuario requiera.	Exigible	N/A		
RAA02	**Registro paciente:** Validación de los pacientes admitidos según la normativa vigente, antes de guardar los datos capturados a la hora de ejecutar la admisión tiene que generar un numero de ficha clínica único en caso de que no tenga asociado uno. Permite registro de admisión de pacientes sin RUN vigente (pacientes no identificados, pacientes extranjeros, recién nacidos), registrando los siguientes datos como: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y otros, siempre y cuando se establezca como paciente no identificado. Además, debe permitir fusionar el RCE (Registro Clínico Electrónico) cuando el paciente pueda ser identificable mediante RUN, Pasaporte, DNI y otros medios legales.	Exigible	N/A		
RAA03	**Identificación paciente programa especial:** El sistema debe permitir identificar si un paciente es SENAME, PRAIS, y/o funcionario, entre otros.	Necesario	4		
RAA04	**Actualización de datos:** Permite al momento de la admisión del paciente, modificar datos de contactabilidad y registros que deben actualizarse (religión, pueblos originarios, discapacidad). Además de visualizar fecha de la última actualización y quien la realizó.	Exigible	N/A		
RAA05	**Admisión- confirmación de cita:** Permite registrar confirmación de cita de un paciente cuando tenga	Exigible	N/A		

	programada una atención de especialidad.				
RAA06	**Oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS y otras):** Permitir al personal consultar información histórica y futura ingresando datos del paciente como RUN o nombre. El sistema debe poder mostrar todas las prestaciones del paciente en sus diferentes estados: citados, pendiente de gestión a citación, eliminados, NSP (no se presenta), en un periodo determinado, mostrando fecha/hora, especialidad, profesional, asistencias e inasistencias y motivos de baja, por ejemplo: fechas de agendamiento de consultas, procedimientos, cirugías programadas, citaciones a hospitalizaciones, nacimientos, páginas educativas, entre otros.	Exigible	N/A		
RAA07	**Comprobante de cita de atención:** El sistema debe permitir generar en formato imprimible institucional del establecimiento el comprobante de cita a atención, incluyendo datos del paciente y datos de la cita, como: • Nombre del paciente. • Edad. • Run. • Previsión. • Ficha clínica. • Fecha y hora de la citación. • Estado de la cita. • Unidad o servicio. • Otros seguros de salud. • Tipo de profesional. • Especialidad. • Prestación. • Código de prestación. • Medico. Además de los datos de la próxima cita, control.	Exigible	N/A		
RAA08	**Representación gráfica:** Permite visualizar la distribución de box para efectos de distribución de especialidades o generar mapa de box de acuerdo con los médicos disponibles.	Exigible	N/A		
RAA09	**Visualización y búsqueda de citas:** Permite mostrar información respecto a citas existentes, en función de los filtros ingresados, ejemplo: sector, identificación de la persona, fecha / hora, tipo de profesional de salud, con el fin de realizar la verificación correspondiente, previa a la admisión o entrega de información a la persona, en caso de que este se presente equívocamente a la admisión o hubo cambio en su cita.	Exigible	N/A		

	Se debe poder visualizar cuando (fecha-hora) se generó la asignación de la cita.				
RAA10	**Agendar por mapa de derivación:** El sistema debe permitir agendar a un paciente en la especialidad al que fue derivado mediante el mapa de derivación el cual es elaborado por el establecimiento dependiente de la Redes integradas del servicio de salud (RIIS) que incluye las especialidades de la oferta programática de Hospital en concordancia con el sistema primario de salud. Este debe permitir el proceso de derivación, pertinencia clínica y administrativa, priorización de interconsulta.	Exigible	N/A		
RAA11	**Admisión de emergencia:** Permitir en la unidad de emergencia, al seleccionar un paciente como NN, desplegar solo campos descriptivos y/o registros que se puedan inferir de manera visual.	Exigible	N/A		

1.6 Atenciones del Paciente - Episodios

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	**Puntaje**		
RAP01	**Registro de episodio:** Permite registrar todas las atenciones del paciente de forma cronológica o histórica, las atenciones principales y las que están relacionadas a estas. Permite visualizar el historial del paciente (resumen de atenciones) de forma cronológica y parametrizada. Por ejemplo, tipos de atención: ambulatoria, emergencia, hospitalizado, procesos quirúrgicos y unidades de apoyo, servicio/unidad clínica, profesional, entre otras.	Exigible	N/A		
RAP02	**Visualización y búsqueda de atenciones:** El sistema debe desplegar un buscador (lista de atenciones del paciente) según los filtros RUN, nombres y ficha clínica para consultar las atenciones realizadas y los detalles relacionados como: actividades asistenciales realizadas (citas y atenciones del paciente con sus distintos estados de atención). Con un registro histórico, según rango determinado, días, semanas, meses o años.	Exigible	N/A		
RAP03	**Gestión de Atención:** El sistema tiene que entregar una visualización intuitiva de los problemas de salud a lo largo del tiempo, mostrando su evolución en la	Exigible	N/A		

	atención clínica, relacionando las atenciones anteriores.				
RAP04	**Gestión de Atención:** Cierre de atención de pacientes que no esperan atención y posibilidad de revertir esta acción si se requiere.	Exigible	N/A		
RAP05	**Asociación de atenciones:** El sistema tiene que permitir la relación de episodios representando en forma cronológica, cuando se efectué la solicitud desde una unidad de origen hacia otra de destino, en caso de aceptar la solicitud automáticamente debe relacionar el número de episodio anterior con el nuevo episodio generado. El sistema tiene que permitir al seleccionar un episodio, desplegar un listado de todos los episodios referenciados.	Necesario	7		
RAP06	**Gestión episodios ambulatorio:** El sistema permite la creación de un nuevo episodio ambulatorio (consulta nueva) cuando exista una precondición de admisión desde: DAU con indicación de atención, epicrisis con indicación de control al alta hospitalizado, interconsulta en estado inicial.	Exigible	N/A		
RAP07	**Restricción admisión ambulatoria:** En caso de no existir una de las precondiciones mencionadas anteriormente el sistema tiene que restringir la creación de una admisión hospitalaria y/o cita programada. Tiene que contemplar la posibilidad de habilitar o desactivar esta funcionalidad.	Necesario	4		
RAP08	**Gestión cierre de atención ambulatoria, emergencia y hospitalizado:** El sistema tiene que proporcionar una solución para la gestión de cierre de atención automático registrando la fecha y hora en la que se llevó a cabo la acción u evento, en caso de atención ambulatoria tiene los siguientes cierres. Alta médica: se genera por finalización del tratamiento o continuidad en otra red asistencial. Alta administrativa (inasistencia consecutiva): Se solicita cuando el paciente no se presenta durante dos citaciones con contacto efectivo de manera consecutiva. El registro de la alta administrativa debe ser visada por el profesional clínico. Alta administrativa (renuncia voluntaria): La solicitada por el paciente en aquellos casos que exprese su voluntad de no ser tratados. El registro de la alta	Exigible	N/A		

	administrativa debe ser visada por el profesional clínico. El registro del alta se debe basar en la norma técnica 118 para el registro de lista de espera.				
RAP09	**Gestión episodio asociado atención cerrada con múltiples servicios de apoyo y unidades de atención:** El sistema debe permitir la creación de un episodio con múltiples eventos y cierres.	Necesario	4		
RAP10	**Atención clínica de hospitalización, urgencia:** La solución debe contemplar registrar el conjunto de tareas, en un registro clínico electrónico único de los datos del paciente. El software tiene que permitir administrar las operaciones sobre el RCE, para permitir el registro, visualización y modificación conservando los registros anteriores.	Exigible	N/A		
RAP11	**Registro de formularios:** Permite el uso y registro de formularios exigidos por atención abierta, atención cerrada, unidad de emergencia y unidades de apoyo, registro de órdenes de exámenes de laboratorio clínico y medicina transfusional y los respectivos informes de resultados. Que son parte de proceso de atención de pacientes.	Exigible	N/A		
RAP12	**Gestión de la atención GES:** Permitir alertas GES al generar la sospecha y diagnósticos, al momento de atención del paciente (DAU, consulta, epicrisis) y en la generación de Interconsulta. Permitir incorporación y/o modificación según decreto de nuevas patologías al sistema. Además, debe permitir la creación de formulario de notificación, IPD (informe proceso diagnóstico) y de cierre de caso, y ser parte de registro clínico del paciente.	Exigible	N/A		
RAP13	**Alerta pacientes ENO:** El sistema debe permitir notificar aquellos pacientes con diagnóstico ENO (Enfermedad de notificación obligatoria), para alertar al profesional clínico.	Exigible	N/A		
RAP14	**Gestión de la atención GES:** Gestionar patologías GES en todas las etapas de su proceso (sospecha, confirmación, tratamiento, seguimiento y cierre de caso).	Exigible	N/A		
RAP15	**Carga de archivos electrónicos:** Permitir adjuntar cualquier documento digitalizado u archivo en la atención y/o RCE. El archivo tiene que estar disponible para ser solicitado y asociado a un episodio. Almacenado en un repositorio definido con sus respectivas rutas.	Exigible	N/A		

RAP16	**Visualización de documentos electrónicos de atención:** El sistema debe contar con un visualizador para los documentos electrónicos asociados o cargados en la atención y en el RCE, permitiendo ver los documentos y/o archivos (Ejemplo: PDF, PNG. JPG).	Exigible	N/A		
RAP17	**Impresión de documentos electrónicos:** Impresión de un documento electrónico en el formato institucional solicitado. Permitir imprimir cualquier documento creado en la atención. Según rol definido por cada unidad.	Exigible	N/A		
RAP18	**Generación de etiqueta:** Permitir la creación de etiquetas con metadatos (código de barra, data matrix y/o QR, según defina el establecimiento). Para el proceso de admisión, la impresión de brazalete de identificación de paciente que contenga los datos considerados como obligatorios, para los servicios de emergencia, hospitalizados, UHCIP adulto e infanto adolescentes, parto, pabellón, unidad cirugía mayor ambulatoria e insumos clínicos, entre otros.	Exigible	N/A		
RAP19	**Historia clínica de las personas:** El Sistema debe administrar y permitir operaciones como registrar, visualizar registros anteriores y/o modificar conservando un control de cambios visualizando los cambios realizados , sobre los datos clínicos vinculados a atención de salud e historia clínica de la persona, debe ejecutar las operaciones (crear, leer, actualizar, inactivar o inhabilitar) conforme a las actividades asistenciales de la cartera de prestaciones y atenciones del hospital realizadas o por realizar, por ejemplo: consulta nueva médica, control médico, procedimientos médicos , consulta y control profesionales no médicos , procedimientos, consulta inicial kinesiológica, consulta intermedia kinesiología, sesiones kinesiológicas, visita domiciliaria, educación grupal , administración de vacunas, curaciones, toma de muestra, ingreso a programa, ingreso a salud mental, psicoterapia, psicodiagnósticos, consultoría, reunión clínica, todas las que tienen la prestaciones y atenciones de cada profesional, entre otros.	Exigible	N/A		
RAP20	**Insumos, fármacos y prestaciones:** El Sistema debe administrar las operaciones de registrar, consultar, actualizar e inactivar, sobre los datos relacionados a insumos, fármacos y prestaciones, conforme a las	Exigible	N/A		

	actividades asistenciales realizadas durante la atención de salud y las reglas definidas.				
RAP21	**Administración de atención clínica hospitalización**: El sistema debe gestionar las actividades asistenciales de hospitalización registradas en la hoja de indicaciones médicas y profesionales no médicos que da cuenta del resultado de la actividad de atención clínica ejecutada, como también de las actividades asistenciales específicas realizadas por otros profesionales de acuerdo con las indicaciones emitidas.	Exigible	N/A		
RAP22	**Búsqueda de atenciones hospitalizados y procesos quirúrgicos:** El sistema debe permitir la reportería específica del ámbito hospitalario, ejemplo: orden de hospitalización, ingresos, egresos, censo, escalas de categorización entre otros.	Necesario	7		
RAP23	**Firma electrónica según rol autorizado:** Para la certificación de cualquier documento y/o instrumento de uso público debe presentar en su solución la utilización de firma simple en el sistema, tiene que estar integrada en la plataforma y registros.	Necesario	7		
RAP24	**Formulario de registro clínico:** De acuerdo con la selección del paciente, el sistema debe permitir: utilizar y ejecutar el formulario del registro clínico electrónico, basado en la plantilla definida, conforme al tipo de atención a realizar, por ejemplo: preparación del paciente, consulta, control de especialista, atención kinesiológica, rehabilitación, diálisis, entre otros. Además, el sistema debe autocompletar los datos clínicos recopilados en las etapas anteriores.	Necesario	7		
RAP25	**Ubicación de pacientes**: Localizar su ubicación en el área donde se encuentra, dato de localización interna, en base a la admisión por la unidad y/o servicio.	Necesario	4		
RAP26	**Interconsulta a control de especialidad desde servicios de hospitalización:** El sistema debe permitir generar una solicitud de atención desde los servicios clínicos al final de la hospitalización como interconsulta al alta hacia consultorio adosado a especialidad.	Exigible	N/A		

1.7 Interconsulta Interna

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
SII01	**Solicitud interconsulta**: El sistema permite crear una solicitud de interconsulta interna a otras especialidades médicas dentro del establecimiento, asociando un paciente a la especialidad solicitada, estas interconsultas pueden provenir también desde la unidad de emergencias mediante el DAU, hospitalización con epicrisis, creando una lista de espera diferenciando el estado de la atención: Ej; pendiente, inicial y egreso.	Exigible	N/A		
SII02	**Gestión de estado de atención:** El usuario con el perfil autorizado podrá gestionar los diferentes tipos de estados de atención del paciente. El sistema registrará la fecha y hora de todos los estados, desde el estado inicial al egreso.	Exigible	N/A		

1.8 Atención de Emergencias

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
ATE01	**Mapa de piso** • Visualización de los datos demográficos: nombre, edad, fecha nacimiento. • Tiempo espera • Motivo consulta. • Categorización. • Diagnóstico principal. • Alertas. Iconografía de atributos (Estado de camas, indicaciones médicas).	Exigible	N/A		

1.9 Unidad GES

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
GES01	**GES / IPD:** El sistema debe permitir la creación del formulario con los campos correspondientes autocompletando automáticamente los datos del paciente al digitar el Run o nombres. Generar la importación del Informe proceso diagnóstico (IPD), notificación de pacientes ges y cierre de caso en los procesos de atención de emergencia, ambulatorio y hospitalizado, con todos los campos disponibles.	Exigible	N/A		
GES02	**GES / IPD:** Generar la importación del informe cierre de caso en los procesos de atención de emergencia, ambulatorio y hospitalizado, con todos los campos disponibles.	Exigible	N/A		
GES03	**Formulario de excepción de garantía de oportunidad:** El sistema debe permitir la creación del formulario con los campos correspondientes autocompletando automáticamente los datos demográficos del paciente al digitar el Run o nombres.	Necesario	4		
GES04	**Alerta GES:** El sistema debe notificar con una alerta GES, en la ficha clínica que ya tenga realizado a un IPD (informe de proceso diagnóstico) para los diagnósticos mencionados.	Exigible	N/A		
GES05	**GES / Reporte:** El sistema debe generar un reporte de atenciones diarias realizadas en atención ambulatoria con diagnóstico GES correspondiente al paciente.	Exigible	N/A		
GES06	**Reporte programa prestaciones valoradas (PPV):** El sistema debe permitir generar un reporte de programa de prestaciones valoradas para las áreas en que el establecimiento lo estime pertinente. Permitir marcar y seleccionar prestaciones como GES y otorgar reportería.	Necesario	7		
GES07	**Lista de trabajo:** El sistema debe permitir crear una lista de trabajo con sus respectivas comprobaciones de campos de actividades diferenciado para GES.	Necesario	4		

1.10 Diagnósticos

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RDI01	**Diccionarios de diagnóstico:** El sistema debe permitir el registro de conceptos homologables de problemas de salud utilizando esquemas de códigos estándares SNOMED u otros definidos por MINSAL. Integrar con diccionario de terminología cuando esté la integración disponible.	Necesario	7		
RDI02	**Diagnósticos:** El sistema debe permitir que los diagnósticos sean ingresados utilizando CIE o servidor terminológico con mapeo a CIE, y permitir establecer diagnósticos como principal y secundarios diferenciados con patologías ENO (enfermedades notificación obligatorias) y GES. Según la versión de CIE que determine el establecimiento.	Exigible	N/A		
RDI03	**Fundamento diagnóstico**: Permitir el registro de fundamento diagnóstico en texto libre en el RCE.	Exigible	N/A		
RDI04	**Relación episodios:** Los episodios del paciente deben estar relacionados a los diagnósticos registrados previamente y referenciando al personal clínico que realizo la atención, procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados.	Exigible	N/A		

1.11 Gestión del Paciente

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RGP01	**Mapa de piso integrando localizaciones de camas en servicios clínicos, unidades, salas y box:** Permite en servicios clínicos, unidades de emergencia, pabellón, recuperación y unidades de procedimientos ambulatorios, CAE (consultorio adosado a especialidad), servicios de apoyo, generar mapa de piso de unidades clínicas (camas, camillas, sillones, box) identificando el tipo de estado: disponible, ocupado, bloqueado, en reserva), además con despliegue de lista de trabajo de actividades y procedimientos. Con identificación de datos demográficos (nombres, RUN, número de ficha o número de registro, edad, sexo, antecedentes clínicos (procedimientos, diagnósticos), alertas, profesional tratante. Permitir Reporteria.	Exigible	N/A		
RGP02	**Complejización y reconversión de camas:** El sistema tiene que permitir modificar el tipo de cama, es decir, la modificación temporal del tipo de cama y registrar el inicio de la reconversión, debe permitir volver a su estado inicial. Tiene que informar adicionalmente la dotación vigente.	Necesario	7		
RGP03	**Restricción:** El sistema debe impedir que un paciente pueda estar en más de un servicio a la vez. Ejemplo: en listas de trabajo de emergencias y en hospitalización.	Necesario	4		
RGP04	**Reservas de camas:** Operación sobre datos vinculados a reserva de camas en el sistema. Debe administrar las opciones (registrar, visualizar, modificar e inactivar) sobre los datos vinculados a reserva de camas, conforme a las acciones ejecutadas por el usuario.	Exigible	N/A		

1.12 Auditoria de Usuarios del Sistema

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RAU01	**Registro de transacciones realizadas por usuarios:** Registro de todo tipo de transacciones realizadas en el sistema por cada uno de los usuarios, identificando fecha y hora del movimiento como los campos involucrados, dirección (IP) local como pública, incluyendo un módulo para visualizar la auditoría.	Necesario	7		
RAU02	**Reporte:** La solución debe permitir generar un reporte donde se detallen los eventos o actividades ejecutadas por el usuario, así como las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) realizadas en los módulos que tiene acceso el usuario final, la generación del reporte se debe ejecutar a partir de los filtros como Run del usuario, fecha. Permitir la exportación a un formato de herramientas ofimáticas, a lo menos compatibles con suite Microsoft Office y Adobe.	Necesario	7		

1.13 Formularios por Unidad

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RF01	**Creación de formularios:** Contar con una herramienta para la gestión de formularios que permita la creación, edición e inactivación de formularios según los requerimientos de cada unidad (privilegio para el perfil administrador).	Necesario	7		
RF02	**Formularios transversales:** Permitir que los formularios sean parametrizables, con escalas y cálculos, validadores de clasificables (ejemplo IMC, Índice Barthel, Escala Norton, espirometría, escala de Score de Tal, entre otros). Además de datos del paciente, profesional ejecutante del formulario, fecha y hora de la aplicación.	Necesario	7		
RF03	**Impresión de formularios**: Impresión de Formularios en formatos institucionales.	Exigible	N/A		
RF04	**Exportación de formularios:** Permitir exportación de reportes, por parámetros para filtración de	Exigible	N/A		

	registros. Como ejemplo: fecha, profesional que lo ejecuto, prestación y tipo de formulario, en formato homologable a la suite de Microsoft office, PDF u otro solicitado.				
RF05	**Impresión de formularios**: Impresión de Formularios en formatos institucionales.	Necesario	2		

1.14 Reportes del Sistema

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RS01	**Lista de espera de interconsulta de especialidad:** • Generación de reporte de interconsultas de especialidad en espera actualizada y consolidada del establecimiento, por fecha y especialidad. • Generación de reportes de pacientes ingresados en LE (Lista de espera) por fecha y especialidad. • Generación de reportes de pacientes con asignación de horas de atención para la consulta de especialidad. • Generación de reportes de pacientes con confirmación de citas de atención para consulta de especialidad. • Generación de reportes de registro de pacientes con su asistencia. • Generación de reportes de registro del resultado diario de la consulta agendada. • Generación de reportes de pacientes egresados de la lista de espera. • Acceso a la base de datos a encargados o referentes del Servicio de Salud. • Otros reportes solicitados por el Minsal o el hospital.	Exigible	N/A		
RS02	**Generación de reportes órdenes de atención:** El sistema debe generar reportes de OA (órdenes de atención), para permitir la gestión de las solicitudes para dejar constancia de la derivación de atención o derivación de una prestación.	Exigible	N/A		
RS03	**Módulo de generación de indicación de intervenciones y/o procedimientos:** • Emisión de la orden o solicitud de pabellón para	Necesario	7		

	intervenciones quirúrgicas y procedimientos, con la emisión de documentos por médicos y odontólogo. • Generación de repositorio de órdenes de pabellón para intervenciones quirúrgicas y procedimientos. • Generación de reporte de las ordenes de pabellón para intervenciones quirúrgicas, mayores, menores, y/o procedimientos. • Generación de reporte de pacientes ingresados de la lista de espera. • Generación de la lista de espera actualizada y consolidada, con reporte del estado de las citas de atención. • Permitir carga masiva de pacientes ingresados a la lista de espera.				
RS04	**Reportes:** Generación de reporte para visualizar registros mediante navegador WEB. Permitir exportar reportes en los formatos solicitados, por ejemplo: Excel, CSV, XML, para el análisis estadístico requerido por DEIS, MINSAL, en base a parámetros seleccionados por el usuario o los definidos en los REM.	Exigible	N/A		
RS05	**Generación de archivos:** El sistema debe permitir la creación de repositorios de datos en los siguientes formatos: txt, csv, formato homologable a la suite de Microsoft office, PDF u otro solicitado. para carga en plataformas gubernamentales (SNIP, UGCC, UGCQ, egresos hospitalarios, SIGGES, GRD, SIGTE, entre otros).	Necesario	7		
RS06	**Reporte pacientes RUN:** Generación de reporte para la visualizar pacientes que no tengan asociado un numero de RUN, visualizando un listado de aquellos que están dentro de la plataforma sin identificar.	Exigible	N/A		
RS07	**Reporte solicitudes:** El sistema debe permitir la generación de reporte con solicitudes de pabellón realizadas en el establecimiento.	Necesario	4		
RS08	**Reporte de intervenciones:** El sistema debe permitir reportes de intervenciones quirúrgicas realizadas en el establecimiento, diferenciándolas de cirugía mayor, menor, hospitalizado y ambulatoria. Además, debe indicar si el paciente egresado corresponde a lista de espera (LE) (idealmente sumar antigüedad) y el porcentaje de la	Necesario	7		

	programación en tabla a pacientes hospitalizados - LE - COMGES - GES - entre otros.				
RS09	**GES / Reporte:** El sistema debe generar reporte de las estadísticas diarias de urgencia con diagnósticos e interconsultas GES realizadas en urgencia.	Exigible	N/A		

1.15 Archivo

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
ARC01	**Gestión de ficha clínica:** Tiene que contar con un mantenedor de fichas clínicas. Debe autorizar las operaciones de registrar, modificar e inactivar el número de ficha asociado al paciente, este tiene que ser único. El sistema debe restringir asociar un número de ficha que se encuentre relacionado a otro paciente.	Exigible	N/A		
ARC02	**Archivo/trazabilidad fichas:** Permitir manejar el concepto de trazabilidad de fichas clínicas (registro de entradas y salidas de fichas clínicas de la unidad de Archivo), considerando la impresión de código de barras, solicitudes, despachos, devoluciones y seguimiento.	Exigible	N/A		
ARC03	**Archivo /Impresión de resumen RCE:** Permitir la impresión en formato PDF, del resumen de registro clínico electrónico.	Exigible	N/A		
ARC04	**Archivo/ Alerta:** Emitir alertas de paciente fallecido al visualizar los registros y/o realizar modificaciones. Emitir alertas en caso de apertura de fichas clínicas a pacientes sin identificación, ejemplo, NN, RN para seguimiento y regularización de datos.	Exigible	N/A		
ARC05	**Permitir el registro de fallecimiento:** Permitir el registro de fallecimiento para la desactivación en cascada de citas, anulación de recetas, alimentos, egresos de lista de espera, entre otras acciones relacionadas a la atención de paciente. Debe contar con la opción de revertir este proceso.	Exigible	N/A		
ARC06	**Reporte archivo:** • Fichas clínicas despachadas por fecha de entrega identificando la unidad de destino.	Necesario	4		

	• Mostrar el movimiento ejecutado de la ficha por la fecha servicio y responsable				
ARC07	**Creación de ficha:** El sistema tiene que permitir generar la apertura de una ficha clínica tanto de forma automática y/o la asignación manual del número en caso que se encuentre en formato físico. Datos según DS (decreto supremo) 41: 1. Cédula de identidad, pasaporte u otro (dejando la posibilidad de registrar NIP y NN (pacientes sin datos.) 2. Número de identificación de la ficha (única por paciente) asociada a Run o número de identificación según corresponda, fecha de la creación, nombre del prestador, indicando identificación nacional o rol único.	Exigible	N/A		

1.16 Integraciones / Interoperabilidad

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
RI01	**Integración/Interoperabilidad:** Validar en línea la obtención de previsión, para mantener actualizados los datos previsionales y tramos del paciente, así como sus cargas de otros seguros asociados (Ej: PRAIS, ISAPRE, DIPRECA, FFAA y otros), como la condición de fallecidos, dentro de la misma aplicación. Que muestre la fecha de la última actualización de previsión de salud. Permitiendo el autocompletado de estos datos en el registro de admisión presente en todos los módulos del sistema.	Exigible	N/A		
RI02	**Visualización de informes de unidades de apoyo en RCE:** El registro clínico electrónico tiene que incorporar por interoperabilidad y/o integración los informes de exámenes generados en las unidades de apoyo y diagnóstico del hospital (imagenología, laboratorio clínico, banco de sangre, endoscopia, cardiología, urología, otorrinolaringología, odontología, fonoaudiología, oftalmología, anatomía patológica, broncopulmonar, entre otros.) en un formato exportable a página web institucional e imprimible. Sugiero	Exigible	N/A		

	dejar establecido que esta integración y vinculación de los datos, se haga a través de RUT, N° Ficha, NOMBRE DE PACIENTE.				
RI03	**Módulo de envío y recepción de solicitudes de exámenes:** El sistema permite interoperar con el sistema LIS de laboratorio, para enviar y recepcionar las solicitudes de exámenes desde la atención de toma de muestra, unidad de emergencias, los servicios clínicos o servicios de apoyo del establecimiento. Sugiero dejar establecido que esta integración y vinculación de los datos, se haga a través de RUT, N° Ficha, NOMBRE DE PACIENTE.	Exigible	N/A		
RI04	**Interoperabilidad con Sistema de información laboratorio (LIS):** El sistema tiene que permitir la interoperabilidad del sistema de información del laboratorio existente y en sus futuras versiones que posea el laboratorio del establecimiento. Debe permitir visualizar en el RCE los informes de resultados.	Exigible	N/A		
RI05	**Integración con sistema de información radiológica (RIS) y PAC'S.** El sistema permite la interoperabilidad con el sistema RIS de imagenología y a su vez con el PAC'S. El proceso de integración tiene que contar con la tecnología HL7-XML, y DICOM en el caso de la visualización de imágenes. Debe permitir realizar la gestión de las ordenes de exámenes (envío y recepción), registrar datos demográficos, visualizar solicitudes de exámenes, agendar paciente, registro en RCE de las imágenes e informes. Además, debe poder integrar los resultados de exámenes en el RCE del paciente, presente del HIS. Sugiero dejar establecido que esta integración y vinculación de los datos, se haga a través de RUT, N° Ficha, NOMBRE DE PACIENTE.	Exigible	N/A		
RI06	**Integración con equipos médicos** Permitir la conexión e integración de equipos médicos (monitores multiparámetros, máquinas de anestesia, torres endoscopia, ecocardiógrafos, ecógrafos entre otros) y que la información obtenida sea parte de registro clínico del paciente, con registro de cada evento.	Exigible	N/A		
RI07	**Sistemas complementarios:** Tiene que permitir interoperabilidad e integraciones con los desarrollos existentes en el hospital, como	Exigible	N/A		

	nuevos desarrollos de software y evoluciones del ciclo de vida.				
RI08	**Interoperabilidad / Integración con el sistema de farmacia** El sistema debe permitir la integración y/o interoperabilidad, para la ejecución del despacho de la receta con sus prescripciones, desde a atención ambulatoria, unidad de emergencia, servicios clínicos y los servicios de apoyo diagnóstico. Tiene que permitir el envío de las recetas y sus prescripciones con el correspondiente estado de despacho a los sistemas.	Exigible	N/A		
RI09	**Interoperabilidad / Integración con el Sistema de Banco de Sangre** El sistema debe interoperar con el sistema de banco de sangre, para realizar: • Recepción y envío de solicitudes de exámenes y las ordenes de transfusión, debe integrar los informes de resultado de exámenes.	Exigible	N/A		
RI10	**Interoperabilidad / Integración con el Sistema de Anatomía patológica** El sistema permite interoperar con el sistema de anatomía patológica que se encuentre operativo en el hospital, para el envío y/o recepción de una orden de examen.	Exigible	N/A		
RI11	**Visualización de resultados desde el Sistema de Anatomía Patológica:** Debe permitir visualizar en el RCE los informes de resultados de imágenes.	Exigible	N/A		
RI12	**Interoperabilidad / Integración ERP:** El sistema debe integrarse con el ERP del hospital que se encuentre en producción, considerando sus actualizaciones y futuras modificaciones en las versiones del software	Exigible	N/A		
RI13	**Integración e interoperabilidad con sistema Licencia Médica:** Permitir la integración con el sistema de licencia médica electrónica. El sistema debe permitir interoperar con el sistema de licencia médica electrónica para enviar los datos relacionados o crear el documento respectivo.	Exigible	N/A		

1.17 Programas Especiales

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
PE01	**Incorporar pacientes:** El sistema debe permitir clasificar al paciente dentro de un programa especial al cual se relacione.	Necesario	4		
PE02	**Administrador de programas:** El sistema tiene que contar un mantenedor de programas especiales para la incorporación o desactivación, registrando fecha del registro modificado.	Necesario	4		
PE03	**Visualización pacientes derivados:** Los encargados de programas especiales deben visualizar los pacientes derivados a sus propios programas.	Necesario	4		
PE04	**Encargado de programa especial:** Debe contar con la opción de egresar al paciente por alta clínica y/o administrativa, según normativas existentes.	Necesario	4		

2 Proceso de Atención Unidad de Emergencia Hospitalaria

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
UEH01	**Categorización ESI:** Permite cumplir con protocolo de categorización de urgencias ESI para dar la prioridad correspondiente a la atención del paciente. Realizar categorización según el nivel de urgencia (ESI1, ESI2, ESI3, ESI4 Y ESI5) permitir al usuario registrar la categorización en forma manual en urgencia Gineco obstétrica.	Exigible	N/A		
UEH02	**Mapa de piso:** Representación gráfica de la distribución de salas, box, camillas de la unidad de emergencia en sus áreas de adulto, pediátrico y gineco-obstetra. Controlando el movimiento de un paciente por las unidades funcionales. El proveedor debe describir la solución de trazabilidad.	Exigible	N/A		
UEH03	**Mapa de piso, pacientes que permanecen en UEH:** El sistema debe registrar a los pacientes que permanecen en la unidad de emergencia por espera de cama en servicios clínicos. Debe admitir un paciente en la unidad de emergencias con un número de episodio correspondiente (DAU) a esta unidad, al ejecutar el evento de hospitalización tiene que generar un nuevo número de episodio de hospitalizado, el cual debe estar relacionado con la atención vigente en la unidad de emergencias. Sólo al cerrar el episodio de hospitalizado tiene que cerrar el episodio relacionado. Permitiendo registrar indicaciones en el episodio de emergencias hasta que se cumpla la condición de cierre de hospitalizado y/o emergencias.	Necesario	7		
UEH04	**Categorización y atención clínica:** Debe permitir el registro de la categorización y atención clínica de emergencias (datos relacionados a las mediciones realizadas. Por ejemplo: temperatura, presión, saturación O2, frecuencia cardiaca, etc., incluyendo procedimientos realizados, solicitud de examen, entre otros), con posibilidad de identificar este tipo de registros en la ficha del paciente y a la alta clínica.	Necesario	7		

UEH05	**Registro plan de cuidados:** Formulación del plan de cuidados y nuevas indicaciones al plan de cuidado, según rol autorizado. El sistema debe permitir al rol autorizado registrar el plan de cuidados del paciente, de acuerdo con las indicaciones de observación, como también indicaciones de tratamiento farmacológico y/o no farmacológico. Las acciones planificadas deben contener al menos las actividades asistenciales a realizar, la periodicidad de ejecución, otras indicaciones específicas.	Necesario	7		
UEH06	**Generación de receta médica por rol autorizado:** El sistema debe permitir al rol autorizado crear una receta médica, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Permite integración a sistemas de dispensador automático de medicamentos e insumos.	Exigible	N/A		
UEH07	**Registro de indicaciones:** Para las indicaciones parametrizadas, se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo. El registro de indicación indicaciones posibles son: • Tratamiento farmacológico o no farmacológico, con emisión de las recetas médicas si es necesario. • Tratamiento administrado dentro de la unidad de emergencia. • Indicación de exámenes. • Solicitud de evaluación de interconsultor. • Para las indicaciones ejecutadas, se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo, de acuerdo con la plantilla creada. Los procedimientos posibles son: • Toma de muestras. • Ejecución de exámenes. • Suministro de tratamiento farmacológico o no farmacológico. • Además, debe cumplir con el formato establecido en la normativa de egreso hospitalario y registros de calidad, donde se establece el registro de quien recibe la documentación al alta del paciente. • Solicitud de procedimientos UPA de urgencia. • Educación a paciente y familiar.	Necesario	7		

UEH08	**Accesibilidad:** El sistema además del acceso de usuario y contraseña debe considerar el uso de herramientas de control de acceso como tarjetas RFID o códigos QR de identificación.	Necesario	7		
UEH09	**Registro de paciente:** Permite el registro de admisión del paciente con fecha y hora, previsión, motivo de consulta y emitir alarmas en caso de accidente de tránsito, escolar o trabajo, paciente ISAPRE. Por otra parte, registrar el origen del ingreso del paciente a la unidad.	Necesario	7		
UEH10	**Indicación de hospitalización**: Permite solicitar la hospitalización de un paciente. Y medir los tiempos de espera desde la indicación de hospitalización hasta que sea ubicado en una cama de la dotación.	Exigible	N/A		
UEH11	**Derivación de pacientes:** Permite derivación a CAE (consulto adosado a especialidades), con el DAU de urgencia, debe generar una lista de espera, según mapa de derivación interna.	Necesario	7		
UEH12	**Registro de atención:** Permite registrar los tiempos de atención durante el periodo de estadía en la Urgencia: • Fecha/Hora de atención en admisión. • Fecha/Hora de categorización. • Fecha/Hora de atención por TENS. • Fecha/Hora de atención de profesional clínico. • Fecha/Hora de atención de médico. • Fecha/Hora indicación de observación. • Fecha/Hora de alta médica. Fecha/Hora de alta administrativa.	Exigible	N/A		
UEH13	**Atención de emergencias:** Debe incluir un mapa de piso o tablero con presentación de alertas por tiempo de espera prolongado y de acuerdo con la categorización del paciente según ESI. Desde que el paciente es admitido, hasta que se inicia la atención médica.	Necesario	7		
UEH14	**Lista de trabajo**: El sistema debe mostrar la lista de trabajo actualizada, con los pacientes que se encuentran en espera de atención, ordenada y filtrada según preferencia preestablecida o especificada por el usuario. En ella, se deben mostrar los datos requeridos para la gestión necesaria, por ejemplo: datos del paciente, fecha / hora de ingreso, tiempo de espera, categorización previamente realizada, motivo de consulta.	Necesario	7		

UEH15	**Atención de emergencias:** El sistema debe desplegar la página de trabajo de selección de demanda y/o selector, facilitando el acceso a los diferentes elementos requeridos, ejemplo: lista de trabajo, categorización ESI del paciente. El sistema debe generar y mostrar alertas por tiempo de espera prolongado, de acuerdo con la normativa vigente y/o alerta por no espera de atención para su posterior registro (NEA).	Exigible	N/A		
UEH16	**Registro tiempos de procesos:** Permite registrar tiempos de procesos de atención, emitiendo alerta previa al tiempo máximo permitido: 1. Desde categorización hasta atención médica. 2. Desde atención médica hasta resolución de caso (máximo 6 horas) 3. Desde indicación de hospitalización hasta que el paciente se encuentra ubicado en su cama de destino. (máximo 12 horas). 4. Énfasis en pacientes C2.	Necesario	7		
UEH17	**Modificación manual del estado de la atención** El sistema debe permitir al usuario modificar el estado de la atención desde la lista de pacientes presentada, de acuerdo con los escenarios: 1. Categorizado en espera de atención 2. En proceso de atención 3. Se retira sin atención 4. Egresado Otros estados especificados	Necesario	4		
UEH18	**Mapa de piso:** Permite mostrar el mapa de ubicaciones de la unidad de atención de emergencia, considerando que la ubicación puede ser una sala (box) de atención, una ubicación (camilla) dentro de la sala de observación, una ubicación (salas de espera interna y externa). En cada una de estas ubicaciones, se debe mostrar su situación de ocupación (disponible, en uso) en forma visiblemente distinguible. Particularmente, si se encuentra "en uso", entonces se debe mostrar datos resumidos de la atención, como: datos del paciente y alertas de trabajo para el equipo de emergencia, cuando se cumple el tiempo para la ejecución de una actividad asistencial en particular. Debe indicar con iconografía estándar los procedimientos o acciones pendientes, en espera de	Necesario	7		

	procedimientos de enfermería, en espera de reevaluación.				
UEH19	**Asignación de una ubicación a un paciente en espera de atención:** El sistema debe permitir seleccionar un paciente desde la lista presentada y vincularla a una ubicación específica. Permitir cambio de box y registro de historial de box, dentro de la misma unidad. Desde una ubicación asignada, el sistema debe permitir indicar la nueva ubicación asignada al paciente (Por ejemplo: sala de tratamiento complejo, imagenología, sala de espera interna, sala de tratamiento transitorio). Debe permitir la trazabilidad y seguimiento de ubicación del paciente con el fin de mantener la continuidad de la atención.	Necesario	7		
UEH20	**Generación de alarma de derivación:** Permite generar una alarma de sugerencia de derivación a profesional médico, en caso de pacientes con alguno de los siguientes diagnósticos de enfermedad no transmisible: Infarto agudo de miocardio, Diabetes mellitus, Enfermedad renal crónica, Hipertensión arterial, Accidente cerebrovascular, Insuficiencia cardíaca descompensada, Asma, EPOC, Intento o ideación suicida, agitación psicomotora, trastorno de pánico y violencia. Para su posterior confirmación y derivación médica desde la unidad de emergencia a establecimientos de atención primaria de salud. Con el objetivo de cumplir con el compromiso de gestión.	Necesario	7		
UEH21	**Despliegue de la lista de trabajo específica por rol, acorde a la sala (box) de atención / paciente seleccionada:** El Sistema debe mostrar las tareas pendientes por realizar a un paciente, de acuerdo con el rol autorizado que realiza la consulta. La lista debe estar ordenada y filtrada según preferencia preestablecida o especificada por el usuario. En ella se deben mostrar tareas como, por ejemplo: nombre de la tarea, estado de la tarea, fecha / hora de indicación, referencia a una indicación, tipo de procedimiento (exámenes, curaciones, imágenes), entre otros.	Necesario	7		
UEH22	**Alta del paciente:** El alta debe estar condicionada a que estén llenos los campos obligatorios y todas las indicaciones en los campos según correspondan.	Exigible	N/A		

	Campos obligatorios: evolución, examen físico, anamnesis, diagnóstico, indicaciones; receta, laboratorio, Rx, (en caso de ser necesario), procedimientos realizados, DAU. Permitir la impresión del DAU. Posterior al alta o egreso, se debe generar la liberación de un paciente desde una ubicación específica y/o asignada, el sistema debe permitir desvincular el paciente del lugar, dado un motivo específico, por ejemplo: alta a domicilio, trasladado a otro servicio clínico (hospitalización) o establecimiento de salud, fallecido, hospitalización domiciliaria, fuga, rechazo de atención. El sistema debe registrar el egreso del paciente el cual puede ser domicilio u hospitalización. En base a reg. 1.3 estándar de acreditación.				
UEH23	**Generación de alerta**: Permite generar sospecha diagnóstica y diagnósticos con alarmas que avisen ante enfermedades de notificación obligatoria (ENO), patologías GES, incorporar clave verde (en caso de pacientes con Glasgow <7), Ley de urgencia. Donde el sistema permita generar los formularios de notificación correspondientes.	Necesario	7		
UEH24	**Registro de valoración de enfermería por el rol autorizado:** El sistema debe permitir al rol autorizado (ejemplo: TENS, Enfermera) registrar la valoración de enfermería realizada, incluyendo datos como: temperatura, presión arterial, saturación O2, frecuencia cardiaca, evaluación general (signos vitales y todo registro, debe aparecer ordenados cronológicamente). Debe permitir el registro de indicaciones y plan de cuidados de enfermería. Ejemplos: cambio de posición, aseo cavidad, aseo genital, instalación y verificación de brazalete, barandas en alto, cama frenada, evaluación de la contención, procedimientos y acompañamiento familiar u otro tutor a cargo. Debe considerarse que debe tener monitoreo de signos vitales básicos y avanzados.	Necesario	7		
UEH25	**Registro de evaluación clínica e indicaciones por el rol autorizado:** El sistema debe permitir al rol autorizado registrar las notas clínicas, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente, durante su	Necesario	7		

	permanencia en la sala de atención o de observación, abarcando acciones de evaluación clínica para determinar el diagnóstico y la evolución del paciente, como también la emisión de las indicaciones necesarias y/o la ejecución de determinados procedimientos. Los datos asociados a evaluación clínica deben tener relación con: • Motivo de consulta. • Antecedentes clínicos. • Antecedentes familiares y sociales. • Anamnesis • Hábitos • Exploración física. (con un dibujo del cuerpo, para poder indicar y marcar en el dibujo, la zona afectada y evaluada). • Escala EVA, Glasgow y otras que defina el establecimiento. • Las diferentes escalas de calidad y seguridad del paciente. • Hipótesis diagnóstica o diagnóstico. (búsqueda clínica que sea homologado internamente a CIE10. No permitir el diagnóstico en texto libre. Fundamento diagnóstico y otros, permite redacción en texto libre.				
UEH26	**Ejecución de indicaciones:** Para el registro de indicaciones, el sistema debe permitir al rol autorizado registrar las notas clínicas, en orden cronológico y/o separado por filtros según necesidad, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente, durante su permanencia en la sala de atención o de observación, en donde se realizaron los procedimientos acordes a las indicaciones entregadas. Para las indicaciones ejecutadas, se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo, además, vincularlo a la orden correspondiente si lo amerita. Los procedimientos posibles son: • Curaciones simples y avanzadas. • Exámenes de imagenología. • ECG • Instalación de sondas. • Tratamiento kinesiológicos y terapéuticos de otros profesionales • Toma de muestras.	Necesario	7		

	• Preparación del paciente para cirugía. • Suministro de tratamiento farmacológico o no farmacológico. • Traslado del paciente. Al mismo tiempo, se debe permitir registrar el motivo de rechazo de un tratamiento, en caso de que sea la voluntad del paciente. Indicaciones con campos obligatorios que no permita avanzar sin su llenado.				
UEH27	**Atención de Emergencias:** Debe permitir visualizar una única lista de pacientes (por área: adulto, pediátrica y gineco-obstétrica) y sus respectivos estados (admitido, categorizado, en box) y visualización rápida y/o iconos, respecto de los cambios de indicaciones. Acceso rápido y fácil a la historia clínica (transversal y desde cualquier ámbito) del paciente, con registro previo.	Necesario	7		
UEH28	**Generación de solicitud:** Permite la generación de solicitud de hospitalización, solicitud de IC Interna en el establecimiento, solicitud de procedimiento en unidades de apoyo, ordenes de exámenes (imagenología, exámenes laboratorio, banco de sangre).	Exigible	N/A		

2.1 Proceso de Atención Urgencia Gineco-obstétrica

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
UGO01	**Atención de Urgencia**: El sistema además del acceso de usuario y contraseña debe considerar el uso de herramientas de control de acceso como tarjetas RFID o códigos QR de identificación	Necesario	7		
UGO02	**Atención de Urgencia:** Debe cumplir con protocolo de categorización de Emergencias Gineco-obstétricas (C1-C5) para dar la prioridad correspondiente a la atención del paciente. Según protocolo de categorización tiempos: C1: Inmediato C2: 30 minutos C3: 120 minutos C4: 150 minutos C5: 180 minutos Los tiempos se establecen en base a lo que determine el hospital.	Necesario	7		
UGO03	**Atención de Urgencia:**	Necesario	2		

	Permita emitir alerta tipo recordatorio a profesional de Matronería, en pacientes categorizados como C2 al cumplir 25 minutos posterior al ingreso a box de atención.				
UGO04	**Atención de Urgencia:** Representación gráfica de la distribución de salas, box, camillas de la unidad. Controlando el movimiento de un paciente por las salas de urgencia.	Exigible	N/A		
UGO05	**Atención de urgencia:** Debe permitir el registro de la categorización y atención clínica de urgencias (datos relacionados a las mediciones realizadas. Por ejemplo: temperatura, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca materna y fetal, incluyendo procedimientos realizados, solicitud de examen, ecografías obstétricas y ginecológicas, etc.) con posibilidad de identificar este tipo de registros en la ficha de la paciente.	Exigible	N/A		
UGO06	**Atención de urgencia:** Permite la confección de hoja de observación con datos administrativos obtenidos previamente.	Necesario	4		
UGO07	**Atención de urgencia:** Si la paciente tiene indicación de pasar a sala de observación, el sistema debe mostrar hoja de observación para ser rellenada.	Necesario	4		
UGO08	**Atención de urgencia:** Con respecto al registro en hoja de observación, en el caso que no se realice un procedimiento predefinido, por no estar indicado, debe permitir la opción predeterminada "no aplica" o "no corresponde". Con el objetivo de no dejar espacios de indicaciones en blanco.	Necesario	4		
UGO09	**Atención de urgencia:** Posterior al alta médica desde la sala de observación, el sistema debe emitir un alerta tipo recordatorio a perfil de matrona, que diga: "firma de paciente en hoja y libro de observación".	Necesario	2		
UGO10	**Reporteria: Permitir generar reportes e informes relacionados con:** • Pacientes categorizadas como C2. • Seguimientos foliculares en unidad de Urgencia. • Pacientes ingresadas a sala de observación. • Vaciamiento y drenaje de bartolinitis ambulatoria.	Necesario	4		
UGO11	**Atención de urgencia:** Que el sistema no permita el cierre de hoja de observación si ésta no se encuentra con todos los datos registrados.	Necesario	2		
UGO12	**Atención de urgencia:**	Exigible	N/A		

	Permite solicitar la hospitalización de un paciente y medir los tiempos de espera desde la indicación de hospitalización hasta que sea ubicado en una cama de la dotación.				
UGO13	**Atención de urgencia:** Debe permitir el registro de alta clínica y sus diferentes alternativas, derivación y emisión de DAU de urgencias. Intercomunicado con admisión.	Exigible	N/A		
UGO14	**Atención de urgencia:** Debe incluir herramienta de tipo cuadro de mando para gestión de tiempos de espera. De acuerdo con la categorización del paciente, C1-C5 el cuadro debe mostrar la cantidad de pacientes según categorización y mayor tiempo de espera. Desde que el paciente es admitido, hasta que es dado de alta de la unidad de emergencias. Gestionar la actividad a través de colores e iconos, que reflejan el estado del paciente y su categorización. Activación de alertas por tiempo de espera prolongado, el sistema debe generar y mostrar alertas por tiempo de espera prolongado, de acuerdo con la normativa vigente o alerta por no espera de atención.	Exigible	N/A		
UGO15	**Prescripción:** Generación de receta médica por rol autorizado. El sistema debe permitir al rol autorizado crear una receta médica, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados.	Exigible	N/A		
UGO16	**Atención de urgencia:** Permite integrar ficha clínica perinatal, ficha de recién nacido, ficha hospitalización ARO, ficha hospitalización ginecología, ficha de observación de amamantamiento, ficha peritaje, ficha de hospitalización por causa materna.	Necesario	7		

3 Proceso de atención Unidad de parto y preparto integral.

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
PP01	**Integración e interoperabilidad:** El sistema permite integración e interoperabilidad con software de libro de parto**,** de tal manera que al ingresar el RUN de un paciente se llenen automáticamente los datos consultados en anamnesis para ficha clínica.	Exigible	N/A		
PP02	**Registro:** Datos de urgencia gineco-obstétrica mediante interoperabilidad e integración con el software de libro de parto disponible debe completar los siguientes datos. • RUN. • Nombre. • Dirección. • Edad. • Fecha de nacimiento. • Migrante. • Nacionalidad. • Pueblo originario. • Beneficiario. • Previsión. • Grupo sanguíneo. • Rh. • Consultorio. • Edad gestacional. Embarazo controlado.	Necesario	7		
PP03	**Atención de paciente:** El sistema computacional de parto debe permitir tener definidos los datos de carácter obligatorios los cuales se notificarán en caso de no ser completados, en caso de registrar el alta se definirán los datos obligatorios para cerrar el registro, estos se definirán a la hora de la implementación del sistema.	Necesario	7		
PP04	**Visualización de piso:** Representación gráfica de la distribución de box, camillas y cunas de la unidad de parto.	Exigible	N/A		
PP05	**Indicación de hospitalización:** Permite solicitar traslado de un paciente y medir los tiempos de espera desde la indicación de hospitalización hasta que sea ubicado en una cama de la dotación.	Exigible	N/A		
PP06	**Integración e interoperabilidad:** Permite integración a sistemas de dispensador automático de medicamentos e insumos que se encuentre operativo en el hospital.	Exigible	N/A		
PP07	**Prescripción:** Generación de receta médica por rol autorizado. El sistema debe permitir al rol autorizado crear una receta	Exigible	N/A		

	médica, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados.				

4 Proceso de Atención de Intervención Quirúrgica

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
PQ01	**Lista de espera:** El sistema debe permitir la visualización de la lista de pacientes en espera de atención quirúrgica. En esta lista, se debe mostrar un conjunto de datos asociados al paciente, en los que se debe contener, a lo menos: RUN, nombre completo, edad, sexo, diagnóstico, lugar físico y origen, GES o no GES, previsión, intervención quirúrgica requerida (código MAI), plano y lateralidad, fecha de indicación de la intervención quirúrgica requerida, especialidad, tipo de prioridad. Los pacientes que se encuentren en la lista de espera deben ser categorizados en los siguientes tipos de estados: • En espera. • En evaluación. • Programable. • En tabla. Egresado (Basado según la normativa 118).	Necesario	7		
PQ02	**Lista de espera:** El sistema debe permitir aplicar filtros en la lista de pacientes por cada columna existente. Por ejemplo, para enlistar sólo los pacientes por especialidad, origen, estado, sólo pacientes no institucionales, pacientes GES, y otros datos definidos por el establecimiento. Desde esta lista, el sistema debe permitir seleccionar un conjunto de usuarios para ser ingresados en la propuesta de pacientes para intervención quirúrgica (tabla quirúrgica).	Necesario	7		
PQ03	**Lista de espera:** Una vez que un paciente en lista de espera ha sido intervenido quirúrgicamente, el sistema deberá mostrar esta actualización automáticamente en la lista de pacientes en espera de atención quirúrgica, indicando que el paciente ha sido operado y la fecha de la intervención.	Exigible	N/A		
PQ04	**Lista de espera:** El sistema debe generar una alerta emergente a los jefes de unidades	Necesario	4		

	cuando un paciente en lista de espera este por vencer, para que puedan ser ingresados a la propuesta de tabla quirúrgica. Ordenadas por fecha y priorización.				
PQ05	**Lista de espera:** El sistema debe generar un reporte de las intervenciones quirúrgicas suspendidas, mostrando el motivo de la suspensión.	Necesario	4		
PQ06	**Planificación de pabellones: Tabla quirúrgica** Despliegue de lista de pacientes para intervención quirúrgica, según lo que requiere la programación: • Lista de pacientes con indicación quirúrgica desde unidad de emergencias para tabla de pabellón de Urgencia. • Lista de pacientes propuestos por servicios clínicos para la creación o modificación de la propuesta de tabla quirúrgica. • Lista de pacientes en lista de espera y GES programables, para ingreso a tabla quirúrgica definitiva. • Lista de solicitudes externas para pacientes no institucionales como por ejemplo pensionados.	Exigible	N/A		
PQ07	**Planificación de pabellones:** La solicitud de ingreso a tabla quirúrgica debe realizarse en cada unidad o servicio de origen y debe completar los siguientes requerimientos: • Profesional solicitante. • Datos generales: Nombre, RUN, edad, ficha, previsión. • Fecha-Hora de la solicitud. • Fecha-Hora de cirugía. • Diagnóstico. • Cirugía por realizar con código Fonasa: debe permitir el ingreso de más de un código. • Condicionalidad con motivo. • Equipo quirúrgico completo. • Instrumental necesario. • Fecha de ingreso a lista de espera. • Servicio de origen del paciente. • Paciente GES. • Tipo de pabellón. • Solicitud de hemoderivados. • Tiempo estimado de cirugía. • En que unidad o servicio realizara post operatorio (sala, UCA, UPC). Paciente en aislamiento: tipo de aislamiento.	Necesario	7		
PQ08	**Planificación de pabellones:**	Exigible	N/A		

	El sistema debe permitir el registro del detalle de una intervención quirúrgica programada, por ejemplo: • Equipo quirúrgico. • Requerimientos especiales relacionados a insumos. • Equipamiento. • Servicio de apoyo clínico. Para cada uno de estos, se debe permitir registrar un conjunto de datos específicos. Debe considerar que es posible programar más de una intervención quirúrgica al mismo paciente y horario quirúrgico, con el mismo equipo quirúrgico o diferente, por lo tanto, el sistema debe permitir agregar el detalle por cada IQ.				
PQ09	**Planificación de pabellones:** Si un paciente tiene más de una intervención quirúrgica asignada en un mismo horario, el sistema debe permitir suspensión de una de ellas. Con esta acción, el sistema debe actualizar la información resumida en el horario asignado. Emitir alerta de paciente que este programado en tabla y que tuvo resolución por urgencia.	Necesario	7		
PQ10	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir incorporar una nueva intervención quirúrgica en un horario asignado a un determinado paciente. Con esta acción, el sistema debe actualizar la información resumida en el horario asignado, pudiendo modificar el mismo, dando una nueva asignación en un horario libre.	Exigible	N/A		
PQ11	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir la visualización e impresión de la propuesta de tabla quirúrgica.	Exigible	N/A		
PQ12	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir confirmar las intervenciones quirúrgicas programadas para el día siguiente, según la última actualización de la programación. Consignándolas con el estado de programación de tabla quirúrgica definitiva.	Exigible	N/A		
PQ13	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir imprimir la última actualización de tabla quirúrgica correspondiente a un determinado periodo, en donde se debe incluir todas las intervenciones quirúrgicas programadas, conteniendo datos resumidos o según la preferencia del usuario.	Necesario	4		
PQ14	**Planificación de pabellones:** Una vez aprobada la tabla quirúrgica, el sistema debe derivar las tablas finales a cada unidad o servicio correspondiente, según parámetros establecidos para la restricción de	Necesario	4		

	cambios hasta la hora que se estime pertinente.				
PQ15	**Modificación intervención quirúrgica:** El sistema tiene que permitir registrar los siguientes motivos de suspensiones: • No se presenta. • No cumple ayuno. • Paciente en tratamiento anticoagulante. • Rechaza la intervención quirúrgica. • Ausencia de médico cirujano. • Ausencia de Anestesiólogo. • Falla/falta de insumo o instrumental. • Exámenes alterados. • Patologías descompensadas. • Prolongación de tabla. • PCR (+). • Sin indicación médica. • Otros (en texto libre). Debe permitir la generación de reportes.	Necesario	7		
PQ16	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir el reingreso por complicaciones, permitir al rol autorizado el reingreso del paciente a quirófano por complicaciones durante el periodo de recuperación.	Necesario	7		
PQ17	**Planificación de pabellones:** En el servicio de origen el sistema debe integrar consentimiento informado, la preparación para la cirugía y los documentos necesarios según protocolo vigente de ingreso a pabellón.	Necesario	7		
PQ18	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir crear programación mensual para asignar los pabellones por especialidad, bloque horario, día, fecha, servicios clínicos o unidades quirúrgicas.	Exigible	N/A		
PQ19	**Planificación de pabellones:** El sistema debe permitir visualizar la distribución de las tablas por pabellones.	Exigible	N/A		
PQ20	**Evaluación pre anestésica:** Realizar el registro de evaluación pre anestésica, el sistema debe mostrar la lista de trabajo ordenada y actualizada, con los pacientes que se encuentren ingresados al pabellón, conforme a la admisión previamente efectuada, en ella, se deben mostrar los datos requeridos para la atención, por ejemplo: • Datos del paciente. • Fecha y hora de ingreso. • Diagnóstico. • Intervención quirúrgica.	Exigible	N/A		
PQ21	**Evaluación preanestésica:** Debe incluir las siguientes características de forma obligatoria	Necesario	7		

	para poder generar el formato institucional imprimible: • Datos generales: Nombre completo, RUN, edad, número de ficha. • peso, talla y calculo IMC. • Alergias a medicamentos. • tratamientos actuales. • ASA Mallampati. • Nombre, apellidos, y RUN del anestesiólogo que realiza la evaluación. • Antecedentes mórbidos. • Antecedentes de hipertermia maligna.				
PQ22	**Evaluación preanestésica:** Debe incluir las siguientes características, para la generación de la evaluación preanestésica: • Antecedentes mórbidos, tabaco, OH, drogas. • Anestesias previas. • calculo IMC. • Antecedentes mórbidos • Antecedentes de hipertermia maligna. • Complicaciones anestésicas. • Antecedentes mórbidos familiares. • Capacidad funcional (1,2,3,4) no evaluable. • Prótesis dental. • Ayuno. • Distancia tiro mentoniana. • Apertura bucal. • Exámenes pre operatorios. • ECG. • Plan anestésico. • Otros estudios. Observaciones en texto libre.	Necesario	7		
PQ23	**Evaluación preanestésica:** El sistema debe proveer la funcionalidad que permita crear, imprimir y visualizar un documento de consentimiento informado anestésico, en base a plantilla definida por el establecimiento, auto completando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados.	Necesario	7		
PQ24	**Evaluación preanestésica:** El sistema debe permitir registrar en la lista de trabajo del anestesista, la existencia de una nueva tarea a ejecutar.	Necesario	4		
PQ25	**Evaluación preanestésica:** El sistema debe integrarse con las evaluaciones realizadas y registradas en registro clínico electrónico y debe incluir las diferentes evaluaciones preanestésicas asociadas al evento quirúrgico. • Evaluación de exámenes. • Evaluación de ficha clínica. • Evaluación presencial.	Necesario	7		
PQ26	**Registro de atención:**	Necesario	7		

	El sistema debe presentar una secuencia de los hitos a ejecutar durante una intervención quirúrgica, de acuerdo con la normativa vigente. Estos hitos deben ser activados siempre y cuando el hito anterior haya sido concluido exitosamente, así mismo, junto a la activación, se debe desplegar los elementos necesarios para los registros correspondientes: • Evaluación preanestésica/recepción del paciente. • Recepción del paciente (registro de preparación del paciente por enfermería.) • Primera pausa quirúrgica (Entrada). • Segunda pausa quirúrgica (Antes de incisión de piel). • Administración de anestesia. • Tercera pausa quirúrgica (Antes del cierre). Traslado de paciente.				
PQ27	**Registro de atención:** El sistema debe permitir el registro de los datos clínicos y medicamentos administrados durante la intervención quirúrgica, incluyendo datos como: nombre del medicamento, dosis, unidad de medida, fecha/ hora de administración.	Necesario	4		
PQ28	**Registro de atención:** El sistema debe permitir al profesional competente registrar el fallecimiento del paciente, indicando la situación ocurrida, fecha y hora del evento.	Exigible	N/A		
PQ29	**Registro de atención:** El sistema debe permitir registrar en texto libre, cualquier evento, como ejemplo: Insumo en mal estado.	Exigible	N/A		
PQ30	**Verificación cirugía segura, primera pausa de entrada:** El sistema debe presentar el hito de primera pausa quirúrgica, una vez confirmada la recepción del paciente, debe completar los siguientes datos asociados a la primera pausa quirúrgica: • Datos del paciente (Nombre, Run o número ficha clínica, edad y peso). • Identidad del usuario corresponde a la tabla quirúrgica. • Fecha intervención quirúrgica. • Servicio de origen. • Intervención quirúrgica a realizar. • Brazalete (datos correctos). • Consentimiento informado firmado.	Necesario	7		

	• Exámenes preoperatorios (laboratorio, imagen y electrocardiograma). • Ayuno. • Baño. • Vaciamiento vejiga o micción. • Paciente sin: Lentes, prótesis dental, esmalte de uña. • Preparación intestinal. • Zona operatoria preparada. • Se confirma sitio a intervenir. • Usuario traumatológico sin yeso. • Ropa pabellón sin ropa interior. • Tiene prevención de enfermedad tromboembólica. • Profilaxis antimicrobiana previa a cirugía. • Nombre de antibiótico. • Vía de administración (EV/IM/VO, otros). • Hora de administración. • Observaciones.				
PQ31	**Verificación cirugía segura, segunda pausa:** El sistema debe presentar el hito de segunda pausa quirúrgica (pausa quirúrgica antes de incisión de piel), una vez confirmado el almacenamiento del formulario de primera pausa quirúrgica. Junto a esto, tiene que desplegar el formulario de segunda pausa quirúrgica, de acuerdo con la normativa vigente. El sistema tiene que obtener los siguientes datos: • Datos del paciente (Nombre, Run, Nro. ficha clínica, edad y peso). • Fecha intervención quirúrgica. • Servicio de origen. • Intervención quirúrgica a realizar. • Arsenalera comprueba material, equipo, instrumental estéril, e indicadores virados (Punto crítico). • Pabellonera verifica buen estado y presencia de filtro superior en cajas de instrumental. • Arsenalera verifica buen estado y presencia de filtro inferior en cajas de instrumental. • **<u>Visita preanestésica:</u>** ¿tiempo esperado de intervención quirúrgica definido?	Necesario	7		

	• ¿Antecedentes de alergia? • ¿Tiene riesgo de aspiración aumentado? • ¿Riesgo de hemorragia superior a 500 ml o Riesgo de alto sangrado? Anestesiólogo autoriza cirugía. • **<u>Cirujano confirma verbalmente:</u>** • Identidad del usuario. • Sitio y lado a intervenir. • Cirugía a realizar. • ¿Hay algún paso crítico a considerar desde su punto de vista? Observaciones (Texto libre.)				
PQ32	**Verificación cirugía segura, tercera pausa de salida:** El sistema debe presentar el hito de Tercera Pausa Quirúrgica (antes del cierre), una vez confirmado el almacenamiento de los datos asociados a la intervención quirúrgica. Junto a esto, debe desplegar el formulario de Tercera Pausa Quirúrgica, en el cual debe autocompletar los siguientes datos: • Datos del paciente (Nombre, Run, número de ficha clínica, edad y peso). • Fecha intervención quirúrgica. • Servicio de origen. • Intervención quirúrgica a realizar. • Además, debe permitir el registro de los siguientes datos: • Primer cirujano informa nombre de la intervención quirúrgica realizada. **<u>Recuento inicial:</u>** • Recuento inicial de compresas. • Recuento inicial de gasas. • Recuento inicial instrumental. **<u>Recuento Final:</u>** • Recuento Final de compresas. • Recuento Final de gasas. • Recuento Final instrumental.	Necesario	7		

	• Pabellonera confirma que el etiquetado de las muestras de exámenes diagnósticos sea correcto. • ¿Hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos usados? • Observaciones (Texto libre) Tiene que implementarse de acuerdo con el protocolo de prevención de eventos adversos asociados a procesos quirúrgicos, vigente del hospital.				
PQ33	**Registro de atención:** El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permite crear un documento de Protocolo Operatorio, en base al formato definido por el establecimiento, autocompletando los datos previamente capturados, por ejemplo: • Datos personales del paciente. • Diagnóstico preoperatorio. • Equipo clínico que participó en la intervención quirúrgica. • Intervención quirúrgica realizada. • Fecha de inicio de la intervención quirúrgica. • Fecha de término de la intervención quirúrgica. • Indicación de biopsias. • Asimismo, habilitar el registro de otros datos requeridos, como, por ejemplo: • Diagnóstico post- operatorio. • Detalle de la cirugía. • Tiempo de anestesia. • Tiempo de pabellón. • Pausa de seguridad. • Número de pabellón. • Tipo de anestesia. • Especialidad de origen del paciente. En protocolo anestesia debe permitir escribir indicaciones en texto libre.	Necesario	7		
PQ34	**Registro de atención:** El sistema debe mostrar las diferencias presentadas en el recuento, en caso de que corresponda, deberá generar alertas de fácil visualización que incluya mensajes de toma de rayos X en caso de ser necesario. Esta acción se repite hasta que se encuentren los elementos faltantes. Luego, se confirma la conformidad de las verificaciones de seguridad realizadas.	Necesario	7		
PQ35	**Registro de atención:**	Exigible	N/A		

	El sistema debe presentar el hito de traslado del paciente activado, una vez confirmado el guardado de los datos asociados a la tercera pausa quirúrgica. Junto a esto, debe presentar los elementos vinculados a este hito, permitiendo el registro de los siguientes datos asociados al traslado del paciente: • Fecha / hora de salida del quirófano. • Lugar de derivación Identificación de o los funcionarios que lo trasladó.				
PQ36	**Registro de atención post anestesia:** El sistema debe mostrar una lista de trabajo en la que se encuentren "Recepción de paciente cuidados post anestesia". Además, mostrar los datos requeridos para la atención necesaria, ejemplo: datos de identificación del paciente, intervención quirúrgica, fecha/hora de traslado del quirófano, solicitudes, fármacos.	Exigible	N/A		
PQ37	**Registro de atención post anestesia:** El sistema debe desplegar la página de trabajo de cuidados post anestesia, facilitando el acceso a los diferentes elementos requeridos, tales como: lista de trabajo, historia clínica del paciente, formularios de registro clínico, etc.	Exigible	N/A		
PQ38	**Registro de atención post anestesia:** El sistema debe mostrar la lista de pacientes intervenidos y enviados a cuidados post anestesia. Los registros deben estar asociados a tareas de la lista de trabajo que se encuentran en "recepción de paciente cuidados post anestesia". En la lista, se deben mostrar los siguientes datos requeridos para la atención necesaria, tales como: • Datos de identificación del paciente. • Intervención quirúrgica. • Fecha y hora de traslado del quirófano. Entre otras a definir.	Necesario	7		
PQ39	**Registro de atención post anestesia:** Post operatorio inmediato: Permitir indicaciones en unidad de recuperación de anestesia y contar con escala de egreso BROMAGE y ALDRETE, entre otras.	Necesario	7		
PQ40	**Registro de atención post operatoria:** Registro de evaluación inicial post anestesista por el rol autorizado. El sistema debe permitir registrar los	Necesario	4		

	datos relacionados con la evaluación inicial post anestesia, tales como: • Signos vitales. • Hora de mediciones. • Estado de conciencia. • Evaluación de función ventilatoria. • Presencia de sangrado. • Evaluación de la recuperación anestésica y hemodinamia. • Valorar y registrar escala del dolor. (Eva) Monitorear parámetros fisiológicos.				
PQ41	**Registro de atención post anestesia:** El sistema debe mostrar las tareas pendientes por realizar a un paciente en la atención post operatoria, de acuerdo con el rol que realiza la consulta, la lista de tareas debe estar ordenada y filtrada según preferencia preestablecida o especificada por el usuario. En ella, se debe mostrar los datos requeridos para la atención necesaria, por ejemplo: • Nombre de la tarea. • Estado de la tarea. • Fecha / hora de indicación. • Referencia a una indicación. Como también alertas de trabajo, cuando se cumple el tiempo para la ejecución de una actividad asistencial en particular. Se debe permitir al rol autorizado seleccionar una indicación desde la lista de trabajo y visualizar su detalle.	Necesario	7		
PQ42	**Registro de atención post anestesia:** El sistema debe permitir al rol autorizado registrar el plan de cuidados del paciente, de acuerdo con las indicaciones farmacológicas, como no farmacológicas, emitidas por los especialistas a cargo (primer cirujano y anestesista) en la intervención quirúrgica y durante los cuidados post anestesia. En el plan, se debe indicar mínimamente la actividad asistencial a realizar, periodicidad, indicaciones adicionales, entre otras a definir.	Necesario	7		
PQ43	**Registro de atención:** En los registros de enfermería debe considerar: Tiempos quirúrgicos, pausas de seguridad, preparación de enfermería, registro de enfermería indicando la última actualización con fecha/hora y profesional, prestaciones de acuerdo con cada establecimiento. Más campo de observaciones en texto libre.	Exigible	N/A		
PQ44	**Registro de atención post anestesia:**	Necesario	4		

	El sistema debe permitir al anestesista registrar los datos recopilados durante la evaluación clínica post anestesia, ejemplo: Condición de egreso del paciente				
PQ45	**Registro de atención post anestésica:** El sistema debe permitir al rol autorizado confirmar el traslado del paciente desde la sala de recuperación, efectuando una de las siguientes acciones en la lista de pacientes, o según sea la preferencia del usuario: • Indicando fecha/hora egreso. • Fecha/hora del sistema. • Funcionario que traslada al paciente. • Funcionario que recibe al paciente. Servicio de destino.	Exigible	N/A		
PQ46	**Registro de atención:** Las prestaciones de intervención quirúrgica y sus diagnósticos, deben aparecer según especialidad, CIE 9-código MAI, CIE 10.	Exigible	N/A		
PQ47	**Integración:** Durante el hito de intervención quirúrgica, el componente funcional debe permitir crear la orden de examen para biopsia mediante la integración y/o interoperabilidad con el sistema de Anatomía Patológica autocompletando los datos previamente capturados y permitiendo el registro de otros datos requeridos, como, por ejemplo: exámenes requeridos, identificación de la o las muestras tomadas, permitiendo impresión de esta.	Necesario	7		
PQ48	**Kits de insumos:** El sistema debe mostrar la lista de insumos incluidos en los kits quirúrgicos y permitir al usuario registrar insumos y medicamentos realmente utilizados. Además, calcular automáticamente la diferencia por cada ítem.	Necesario	7		
PQ49	**Reporteria:** El sistema debe permitir crear un registro de evento adverso/centinela según protocolo vigente en formato imprimible.	Necesario	7		
PQ50	**Registros estadísticos**: Debe permitir el registro de la prestación quirúrgica, asociada a codificación MAI, MLE o propio, desde la solicitud de intervención quirúrgica, además de permitir agregar otras intervenciones. Generar reporteria con los valores mencionados.	Exigible	N/A		
PQ51	**Registro estadístico:**	Exigible	N/A		

	Permitir reportería de bases de datos de las intervenciones quirúrgicas realizadas y suspendidas. Donde contenga: Nombres, apellidos, RUN, diagnóstico, cirugía realizada, cirugía programada y/o agregada, fecha de la solicitud, fecha de intervención, fecha de ingreso a la lista de espera, horarios intraoperatorios. En base a lo establecido por la UGCQ de MINSAL.				
PQ52	**Unidad de cirugía mayor ambulatoria:** El sistema debe permitir: Mapa de piso y listas de trabajo modificables teniendo como mínimo los siguientes datos por paciente: • Datos demográficos y de identificación. • Diagnósticos. • Alertas. • Estado de los cupos (traslado, altas, u otras). • Iconografías asociadas a indicaciones y estado de estas. • Identificación y estado de los cupos (camillas, sillones) (ocupado, desocupado, bloqueado, en reserva, otros, diferenciándolos en distintos colores). • Profesional tratante. Pacientes con alta clínica y en espera.	Necesario	7		
PQ53	**Unidad de cirugía mayor ambulatoria:** El sistema debe permitir al rol autorizado registrar la valoración de enfermería realizada al ingreso a la unidad, incluyendo los datos necesarios. Como: • Signos vitales. • Exploración física. • Preparación específica. • Valoración de riesgo de caídas.	Necesario	4		
PQ54	**Unidad de cirugía mayor ambulatoria:** El sistema permite: Impresión de brazalete de identificación.	Exigible	N/A		
PQ55	**Unidad de cirugía mayor ambulatoria:** El sistema permite: • Visualizar registro clínico electrónico con la historia, episodios y procesos clínicos del paciente. • Realizar registro en ficha clínica electrónica para respaldar situaciones como suspensiones, rechazos de intervención, hospitalizaciones.	Necesario	4		

PQ56	**Unidad de cirugía mayor ambulatoria:** El sistema debe permitir egresar al paciente por rol autorizado (enfermera y médico) completando formularios asociados. Imprimir informe de prestaciones que incluyan diagnóstico, procedimiento realizado e indicaciones, además indicar responsable del procedimiento. Aplica a Cirugías ambulatorias (Estándar de acreditación)	Necesario	7		
PQ57	**Unidad prequirúrgica:** El sistema debe permitir: • Agendamiento de exámenes preoperatorios. • Agendamiento de atenciones ambulatorias de especialidades médicas y profesionales.	Exigible	N/A		
PQ58	**Prequirúrgico:** El sistema debe permitir realizar los cambios de estado (actualización exámenes preoperatorios, evaluación preoperatoria, entre otros) a los pacientes con indicación quirúrgica.	Necesario	4		
PQ59	**Unidad prequirúrgica:** El sistema debe permitir visualización de exámenes de imagenología, laboratorio y unidad de procedimiento ambulatorio, así como también solicitar exámenes de dichas unidades. Además, permitir visualización de registro de pabellón central.	Necesario	7		
PQ60	**Unidad prequirúrgica:** El sistema debe permitir: • Registro en sistema clínico electrónico por parte de personal médico y de enfermería de la unidad prequirúrgica. • Registro y cambio de estado preoperatorio en que se encuentra el paciente, por ejemplo: actualización de exámenes, evaluación preoperatoria, pase de especialidad, difiere cirugía, evaluación de caso clínico, examen complementario, programable y programable entregado. Reevaluación médica.	Necesario	7		
PQ61	**Unidad prequirúrgica:** El sistema debe permitir que solamente el paciente en estado preoperatorio programable entregado se agregue a una tabla quirúrgica, los que se encuentren en otro estado preoperatorio solo pueden ser visualizados.	Necesario	7		
PQ62	**Unidad prequirúrgica:** El sistema debe permitir:	Exigible	N/A		

	• Visualización de fecha de ingreso de paciente a lista de espera quirúrgica y/o GES. • Especialidad de origen del paciente • Profesional que indica la intervención quirúrgica. • Registrar inicio Fecha/Hora por unidad prequirúrgica. Registrar Termino Fecha/Hora por unidad prequirúrgica.				

5 Proceso de Atención Cerrada

5.1 Gestión de Pacientes

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
GP01	**Módulo de admisión hospitalizado:** El sistema debe permitir registrar al paciente, modificar datos personales. Tiene que presentar en forma clara y visible los datos personales del paciente para facilitar la comprobación de su identidad durante la atención. El sistema debe poseer un módulo de gestión de hospitalizados, cirugía mayor ambulatoria y pabellón, que permita registrar y actualizar los datos de pacientes, tales como: datos de contacto, previsión, otros datos demográficos (adulto mayor, discapacidad, dependencia, entre otros). Debe visualizar la procedencia del ingreso: ambulatorio programado, ambulatoria espontaneo, servicio de urgencia, traslado desde establecimiento público o privado, Pabellón, recuperación, parto-preparto, hospitalizado de otro servicio clínico o reingreso. Debe contemplar fecha de ingreso, días de estadía previa en caso urgencia u hospitalizado desde otro servicio. Debe contemplar fecha de alta "administrativa y clínica", tiene que contener un campo de texto libre para especificar el nombre del centro de origen del paciente.	Exigible	N/A		
GP02	**Asociar solicitud de cama al episodio de hospitalizado:** Debe ser vinculado desde el episodio de ingreso, para que el proceso de hospitalización tenga trazabilidad en la línea de tiempo. Gestión de solicitudes de hospitalización con códigos únicos de identificación, deben cumplir con la normativa de egreso hospitalario y con la norma de camas del MINSAL.	Exigible	N/A		
GP03	**Módulo de solicitudes pendientes de cama:** El sistema debe contener un módulo en donde se muestren las solicitudes de hospitalización que se encuentren pendientes de ingreso, provenientes de distintas unidades y/o servicios del mismo establecimiento, ejemplo: unidad emergencia hospitalaria, lista de espera unidad prequirúrgica,	Exigible	N/A		

	recuperación, hospitalización domiciliaria.				
GP04	**Solicitar una cama:** El sistema debe permitir sólo la solicitud de cama desde un servicio, desde médico jefe de especialidad o una unidad de origen, la cual haya efectuado previamente una orden de hospitalización.	Exigible	N/A		
GP05	**Bloquear cama y sala:** El sistema debe permitir bloquear una cama que no se encuentra en condiciones para su uso, indicando el motivo correspondiente y quien realiza el bloqueo. Esta acción debe incluir los tipos de bloqueos (En mantención, falta de personal, aislamiento, falta de equipamiento o en procedimiento), además de actualizar el mapa de piso, marcando en forma distinguible el nuevo estado de la cama.	Exigible	N/A		
GP06	**Lista de solicitudes de camas**: Permite desplegar lista de solicitudes de cama recibidas o pendientes de gestionar. El sistema debe mostrar una lista de solicitudes de cama, provenientes de diferentes servicios clínicos internos o de otros establecimientos de salud, tales como: • Solicitudes de hospitalización programada (electiva) o modificación de una existente. • Solicitud desde urgencia, pabellón, recuperación, parto y preparto. • Solicitud por reingreso y hospitalización domiciliaria. • Solicitudes de la red externa o modificación de una existente. • Solicitud de cama por el cuidado de paciente, ejemplo: desde UPC a Médico quirúrgico. Rescate de pacientes ley de urgencia. En cualquiera de ellas, se debe mostrar un conjunto de datos mínimos, por ejemplo: • Datos personales del paciente. • Diagnóstico. • Fecha de inicio programada. • Fecha de término programada. Tipo de cama.	Necesario	7		
GP07	**Módulo mapa de piso (camas) de un servicio clínico de hospitalización:** Permite despliegue del mapa de piso correspondiente a la fecha actual por cada unidad funcional y/o servicio clínico de Hospitalización, en una	Exigible	N/A		

	sola ventana (que se ejecuten todas las operaciones en la ventana). Cada cama debe estar en forma visiblemente distinguible, asociada a un código propio y a su vez con codificación de sala, conforme al conjunto de reglas vinculadas a la programación del establecimiento. Debe mostrar etiqueta de su estado diferenciado por color: ocupada, bloqueada, desocupada, aislada, mantención, reservada, alta, pendiente de alta, basado en la normativa vigente. El tipo de cama clasificado por el tipo de cuidado del paciente, complejidad, demanda de cuidado, cuidados progresivos, camas indiferenciadas. Tipo de cama de acuerdo con los servicios clínicos (médicos quirúrgicos, ginecología y obstetricia, pediatría, unidad de paciente crítico, psiquiatría, unidad de emergencias, diálisis, pabellón, sala de preparto) de acuerdo con la dotación del hospital, tipo de cama funcionales y su reconversión de cama (camas básicas, medianas y alta complejidad). Para las camas programadas u ocupadas con paciente, el sistema debe mostrar un episodio único que registre todo el proceso de hospitalización: • Datos personales del paciente. • Edad. • Sexo. • Tipo de cama. • Riesgo dependencia. • Datos y fecha de intervención quirúrgica. • Datos de Urgencia. • Datos de pabellón. • Fecha de ingreso al hospital y al servicio clínico, traslados. • Fecha de término programada (fecha, estima de alta, fecha de alta). Debe permitir generación de reporte de periodos anteriores de su movimiento y ocupación, como reporte de condición de mapa de piso en tiempo real.				
GP08	**Módulo mapa de piso, agregar prealta:** Al finalizar la atención del paciente, este debe ser ubicado en mapa de piso a una estación temporal llamada "Pre Alta" que debe disponer con camillas y berger. Se designa como espacio temporal, porque es mientras el paciente espera a que se gestione el alta para egresarlo completamente del establecimiento.	Necesario	7		

GP09	**En mapa de piso reconvertir camas:** El sistema debe permitir realizar la reconversión de las camas y una vez finalizado el uso de la cama, devolverlas a su estado inicial. Acción que se realizará de forma manual en el sistema.	Necesario	7		
GP10	**Registro Manual de Gestión de Solicitudes**: Incorporación manual de respuesta y/o aprobación de la gestión de una solicitud de cama recibida. El sistema debe permitir registrar respuesta y/o aprobación de la gestión realizada para una solicitud de cama recibida, ingresando datos mínimamente requeridos, como, por ejemplo: aprobación, rechazo, comentarios. Además, en este mismo módulo, agregar una pestaña para poder gestionar la recepción de un paciente rescatado. Las posibles respuestas son: • Pendiente por no contar con camas disponibles. • Rechazo de una solicitud externa por no contar con camas disponibles. • Solicitud errónea. • Compra a privados. • Gestión de paciente rescatado. • Rechazo por no contar con la prestación requerida. Entre otros.	Necesario	7		
GP11	**Registro manual de paciente rescatado:** En el módulo de gestión de solicitudes, agregar una pestaña o vinculo desplegable, para agregar un registro del informe médico del paciente ingresado (rescatado) e ingresarlo al sistema desde la red externa. Y de esta forma, asignarle la cama reservada anteriormente.	Necesario	7		
GP12	**Visualizar lista de trabajo por camas:** El Sistema debe mostrar la lista de trabajo vinculada al rol de gestor de cama. • Visualizar desde donde proviene y hacia donde será trasladado el paciente. • Solicitud de cama ocupada, bloqueada, aislada, reservada • Solicitud de cama pendiente alta (alta administrativa y clínica). • Solicitudes de cama enviadas a otras entidades de salud, pendientes de respuesta. Cancelar o eliminar solicitud de traslado, en donde debe desplegar	Necesario	7		

	un formulario de cancelación, en donde se seleccionará un motivo por el cual se cancelará la solicitud y dejar detallado las posibles razones.				
GP13	**Visualización de aceptación de solicitud de camas:** El sistema en el módulo de solicitudes debe permitir la visualización de las solicitudes de las camas que fueron aceptadas por los servicios clínicos.	Necesario	4		
GP14	**Ingreso de paciente por cama:** El sistema debe permitir seleccionar al paciente para asignar la cama en la unidad/ servicio al cual será destinado a través de las ordenes de hospitalizaciones. Debe visualizar datos personales del paciente, tales como: nombre, RUN, dirección, número de teléfono, motivo de hospitalización (el cual debe ser un campo obligatorio), fecha y hora de solicitud, prioridad, procedencia, entre otros. Si el paciente irá acompañado, debe tener la opción de datos del acompañante: • Datos de identificación del acompañante. • Relación con el paciente. • Número de teléfono. Dirección.	Exigible	N/A		
GP15	**Reserva de una cama:** El sistema permite la reserva de una cama para las intervenciones quirúrgicas programadas (cirugías electivas) y los traslados del paciente a la red externa, de acuerdo con el periodo de hospitalización indicado en la solicitud. Con esta acción, el sistema debe actualizar el mapa de piso, marcando en forma distinguible la nueva programación efectuada, además, mostrando los respectivos datos resumidos del paciente. Debe permitir reservar la cama y/o modificar la reserva, hasta que el paciente vuelva.	Necesario	7		
GP16	**Asignación de cama:** El sistema debe permitir la asignación de un paciente en una cama disponible, de acuerdo con la verificación del mapa de piso, de acuerdo con el periodo de hospitalización indicado en la solicitud. Con esta acción, el sistema debe actualizar el mapa de piso, marcando en forma distinguible la nueva programación efectuada, además, mostrando los respectivos datos resumidos del paciente.	Exigible	N/A		
GP17	**Interfaz intuitiva del mapa de piso:** Debe permitir la visualización de los pacientes en la sala y las camas	Necesario	2		

	relacionadas, mostrando por cada paciente: • RUN. • Nombre completo del paciente. • Edad actual. • Tiempo de estadía del paciente en cama. Diagnóstico de ingreso.				
GP18	**Traslado del paciente interno (dentro del establecimiento):** Permitir el traslado de un paciente a otra cama dentro de los servicios clínicos del establecimiento, de acuerdo con el cuidado progresivo del paciente, permite la reserva de esa cama para el paciente.	Exigible	N/A		
GP19	**Búsqueda de un paciente de cama asignada**: El sistema debe permitir buscar la cama asignada a un paciente por la fecha actual, de acuerdo con los filtros ingresados, como, por ejemplo: identificación, nombre del paciente, mostrando en forma distintiva las camas que tienen coincidencias con los filtros ingresados.	Exigible	N/A		
GP20	**Mover a paciente a estación de enfermería:** El sistema permite en una ventana visualizar al paciente aceptado por el servicio solicitante en el mapa de piso, y el gestor debe mover al paciente a la estación de enfermería del servicio.	Exigible	N/A		
GP21	**Despliegue del registro clínico del paciente en hospitalización:** Al seleccionar la cama con el paciente asignado, o la atención y /o paciente en particular, por búsqueda de nombre y/o RUN. El sistema debe mostrar el registro clínico del período y/o episodio generado en las distintas actividades asistenciales realizadas al paciente durante la hospitalización, en forma textual y/o gráfica que presenta curva de evolución, días de estadía.	Exigible	N/A		
GP22	**Reasignación de paciente:** El sistema debe permitir la reasignación de un paciente desde la cama asignada a otra cama disponible, dentro de la misma unidad o en otro servicio clínico hospitalario, de acuerdo con el período de hospitalización. Con esta acción, el sistema debe actualizar el mapa de piso, marcando en forma distinguible la nueva asignación efectuada, además, mostrando los respectivos datos resumidos. En caso de que el mapa de piso sea reasignado por otra unidad, se debe notificar su actualización.	Exigible	N/A		

GP23	**Modificación del estado de la cama:** El sistema debe permitir la modificación del tipo de cama correspondiente, según la norma vigente. La tipificación respecto a la disponibilidad de la cama debería ser igual a lo expuesto al censo de cama del departamento de estadística, considerando cama ocupada, disponible, reservada, bloqueada y fuera de servicio, considerando opciones de tipo de bloqueo, causa de inhabilitación, motivo de reserva, entre otros. Con esta acción, el sistema debe actualizar el mapa de piso, marcando en forma distinguible el nuevo tipo convertido.	Necesario	7		
GP24	**Revertir estado y/o asignación de la cama:** El sistema debe permitir revertir o habilitar la asignación de una cama reservada, marcando en forma distinguible su disponibilidad en el mapa de piso. Además de permitir el registro de una justificación del cambio, y así almacenando los datos de todas las transacciones realizadas por los usuarios en el sistema.	Necesario	7		
GP25	**Modificación de datos de la cama designada:** El sistema debe permitir la modificación de los datos vinculados a la cama asignada, como, por ejemplo: fecha de inicio de hospitalización programada, fecha de término de hospitalización programada, tipo de cama.	Necesario	4		
GP26	**Envío solicitud y recepción de camas a la red externa:** Permite recepcionar y enviar las solicitudes de cama desde y hacia a una entidad de salud externa. Si corresponde, el sistema debe interoperar con el sistema de RCE de la entidad de salud externa u otro sistema de gestión, ejemplo: UGCC (unidad de gestión centralizada de casos), para envío y recepción de las solicitudes de cama correspondientes. Debe tener la opción de adjuntar archivos, imágenes, exámenes en distintos formatos, entre otros.	Necesario	7		
GP27	**Generación de alta de paciente.:** Permitir realizar el alta del paciente. • Alta probable (Fecha estimada) • Pre alta (Fecha y hora estimada) • Alta médica. • Fallecido. • Traslado a otro establecimiento • Hospitalización domiciliaria.	Necesario	7		

	• Alta administrativa (Texto Libre). Debe permitir el registro de tiempo y cronometrar cuanto se demora el proceso de alta en cada servicio, permitiendo el registro de la hora en que se traslade el alta a cada unidad.				
GP28	**Visualización de alta de paciente:** Debe permitir visualizar el alta del paciente, representando el proceso de alta con simbología correspondiente que se visualiza por las diversas unidades que participan del proceso. Generando ruta gráfica en la plataforma, que exprese en tiempo cronometrado cuanto se demora el proceso de alta en cada servicio, registrando hora en que se traslade el alta a cada unidad: • Prealta. • Recaudación. • Movilización. Alta del servicio. Permitir identificar el tiempo de espera en cada unidad.	Necesario	7		

5.2 Hospitalizado

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
H01	**Generación de orden de hospitalización:** El sistema permite generar una solicitud de orden de hospitalización redactada sólo por médico o la unidad solicitante, desde las entradas de: Unidad de emergencias, Unidad prequirúrgica (programación de lista espera quirúrgica), parto, preparto, pabellón recuperación, pensionado, hospitalización domiciliaria, consultorio adosado a especialidad, servicios de apoyo, traslados desde otros centros hospitalarios, recintos hospitalarios internos o externos, para poder hospitalizar al paciente. Mediante la orden de hospitalización, que debe tener fecha y hora de la solicitud, el servicio de origen, nombre completo del paciente, RUN, previsión, edad actual, fecha de nacimiento, diagnóstico, sospecha o intervención quirúrgica por la cual ingresa, indicar tipo de cama solicitada, por ejemplo: UCI, UTI adulto, UTI neopediatrica, neonatología, entre otras, con fecha estimada de la hospitalización en el servicio clínico.	Necesario	7		

H02	**Orden de hospitalización unidad paciente crítico (UPC) adulto y unidad tratamiento intensivo (UTI) neopediatrica:** El sistema debe permitir que la orden de hospitalización para cama de unidad paciente crítico (UPC), deba generar una validación por el médico interconsultor de la unidad paciente crítico (UPC) aplicando el criterio de evaluación: Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Con esta orden validada, al gestor de cama le permite la reserva o confirmación de cama UPC u otro servicio clínico.	Necesario	7		
H03	**Visualización de mapa de piso y/o cupos disponibles:** El usuario con rol autorizado, debe poder visualizar la disponibilidad y estado de las camas de su servicio, además de poder mover al paciente a la cama asignada.	Exigible	N/A		
H04	**Aceptación o rechazo de solicitud de camas**: Cada servicio clínico acepta o rechaza la solicitud de cama asignada: el proceso de aceptación se realiza al momento que se utiliza la cama. En el proceso de rechazo, el servicio clínico rechaza la acción y este paciente queda en lista de tareas en el módulo de solicitudes de cama pendientes.	Exigible	N/A		
H05	**Verificación, validación, registro del ingreso de paciente a hospitalización:** Se despliega una lista de verificación para realizar el ingreso clínico del paciente por rol autorizado con la selección de una cama asignada a un paciente recién admitido. Los aspectos más relevantes para mostrar son: • **Paciente correcto**: Se debe mostrar los datos de identificación del paciente para facilitar la verificación correspondiente. • **Asignar cama al paciente:** El profesional encargado mueve al paciente desde estación de enfermería a la cama previamente asignada por el gestor de cama. • **Paciente en la cama correcta:** se muestra la identificación (código único) de la cama para facilitar la verificación correspondiente. • **Documentación clínica exigida para su ingreso**: según indicaciones médicas, por ejemplo: resultados de exámenes, informe de atención de urgencia,	Necesario	7		

	epicrisis por traslado, entre otros. • **Condiciones de preparación previa necesaria:** (ejemplo: paciente que va a cirugía) según indicaciones médicas, por ejemplo: realización de exámenes para cirugía, que los exámenes estén en los parámetros adecuados, ayuno. • Además de lo anterior, el Sistema debe permitir al usuario confirmar el ingreso clínico del paciente, efectuando una de las siguientes acciones, según sea la configuración y/o situación presentada: • **Indicando la marca asociada,** lo que obtiene como: fecha / hora de recepción, la fecha / hora del Sistema cuando realizó dicha acción. **Indicando la fecha / hora de recepción** en forma manual.				
H06	**Mover paciente desde estación de enfermería a cama asignada:** El sistema permite al profesional clínico del servicio (piso) bajo la autorización del gestor de pacientes (GP), mover al paciente desde la estación de enfermería a la cama asignada.	Exigible	N/A		
H07	**Hospitalizado categorización cama:** El sistema debe permitir la categorización de pacientes por riesgo dependencia y evolucionar su registro de estado cada vez que se requiera. (Selección).	Necesario	4		
H08	**Hospitalizado Gestión de pacientes: Lista de trabajo por paciente con cama asignada:** Al seleccionar al paciente el sistema debe mostrar las listas de tareas según indicación médica, de acuerdo con el profesional que realiza la consulta. La lista debe estar ordenada y filtrada según preferencia preestablecida y especificada por el usuario. Debe mostrar los datos requeridos para la atención necesaria, por ejemplo: • Nombre de la tarea. • Estado de la tarea. • Fecha / hora de indicación. Referencia a una indicación.	Necesario	4		
H09	**Pantalla de inicio de la atención clínica del episodio hospitalizado:**	Necesario	4		

	El sistema debe desplegar la página de inicio de atención clínica de hospitalización, permitiendo al usuario acceder a los diferentes elementos requeridos para su gestión, tales como: • Mapa de piso. • Lista de indicaciones, realizadas y pendientes. • Historia clínica del paciente. • Registro clínico del paciente. Formularios de registro clínico.				
H10	**Visualización del historial del registro clínico electrónico:** El sistema permite visualizar el registro clínico del paciente e historial clínico. Visualiza de acuerdo con el episodio por el cual se hace la consulta o la atención recibida. Además, muestra de manera intuitiva el historial clínico del paciente, por ejemplo: • Resumen por tipo de profesional y especialidades. • Resumen por evento. • Resumen por problema de salud. • Resumen por hospitalizaciones previas. • Resumen del proceso quirúrgico. • Resumen de atenciones previas. • Resumen de diagnóstico. Todos estos eventos deben estar realizados en el establecimiento para su visualización.	Exigible	N/A		
H11	**Ingreso del paciente por profesional clínico:** El sistema permite revisar la documentación previa del servicio de origen o procedencia al momento del ingreso del paciente, esta documentación se puede visualizar o imprimir desde el HIS en el registro clínico electrónico.	Exigible	N/A		
H12	**Seguimiento paciente clave verde:** El sistema permite que el módulo de ingreso del paciente, si en evaluación clínica del paciente, quien corresponda en escala Glasgow menor o igual a 7 se pueda etiquetar y/o generar una alerta a la unidad de procuramiento de órganos y a los servicios de apoyo (laboratorio, imagenología, banco de sangre) como paciente "clave verde". La alerta solo será visible para rol autorizado.	Necesario	7		
H13	**Registro de atención inicial con formularios:** Se realiza la anamnesis y valoración del paciente, además se rellenan los documentos que deben estar disponibles:	Necesario	7		

	• Índice de Barthel. • Ingreso de enfermería o matronería. • Hoja de indicaciones médicas y de enfermería. • Categorización de pacientes (Cudyr). • Pauta de resumen individual de categorización de usuarios por dependencia y riesgo. • Hoja de verificación de preparación preoperatoria. • Procedimientos de enfermería. • Hoja de vigilancia con factores de riesgo. • Escalas de valorización de calidad y seguridad del paciente. Entre otros. Todos estos documentos se deben ingresar, registrar y almacenar en el módulo de enfermería al ingreso del paciente al servicio.				
H14	**Registro de atención: Ingreso Médico:** El sistema permite revisar la documentación previa del servicio de origen o procedencia al momento del ingreso del paciente, esta documentación se puede visualizar o imprimir desde el HIS en el registro clínico electrónico. Acá se realiza la evaluación del paciente al ingreso a su servicio clínico, además se rellenan los documentos que deben estar disponibles: • Ingreso médico. • Visualizar los diagnósticos previos. • Registrar hipótesis diagnóstica del paciente o los nuevos diagnósticos realizados. • Hoja de indicaciones médicas, de enfermería y de otros profesionales. • Generar solicitudes e indicaciones de exámenes (laboratorio central, imagenología, anatomía patológica, banco de sangre, unidad procedimientos ambulatorios). • Generar recetas e indicaciones farmacológicas. • Indicaciones de tratamiento terapéutico, procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. • Registro de evaluación médica. • Describir el plan de tratamiento en su ficha clínica.	Exigible	N/A		

	Todos estos documentos se deben ingresar, registrar y almacenar en el módulo de ingreso del paciente al servicio.				
H15	**Registro de atención Ingreso médico a psiquiatría:** El sistema debe poseer una pestaña o vínculo con el cual se desprendan opciones de ingreso del paciente a salud mental o psiquiatría. La ventana nueva debe realizar un despliegue y que se encuentren disponibles los documentos y/o formularios a rellenar, y las escalas a visualizar que son propios del servicio de Psiquiatría adulto y UHCIP.	Necesario	7		
H16	**El Registro clínico del paciente (RCE) hospitalizado**: El sistema en el módulo de registro clínico del paciente hospitalizado debe contener: • Registro de evaluación y evolución clínica. • Generar solicitud de exámenes u ordenes de atención en el sistema. • Generación y registro de Diagnósticos clínicos médicos, de acuerdo con la norma CIE-10. • Registro de enfermería de acuerdo con el diagnóstico de enfermería (Referencia Clasificación y definición NANDA). • Registro de indicaciones médicas (fármacos, procedimientos, tratamientos, régimen alimenticio, entre otras). • Generación de Solicitud de interconsultas hospitalizado. • Generación Informe Proceso Diagnóstico para los casos GES, y notificación de caso GES. • Generación de documentos de Constancia GES. • Generación de Documento de Consentimiento Informado para las diferentes intervenciones quirúrgicas, procedimientos. • Registro evaluación de riesgo dependencia del paciente. • Registro preparación y evaluación del paciente para cirugía o procedimientos. • Registro de procedimientos solicitados y realizados. • Traslado interno del paciente para realización de exámenes. • Registro de boletín ENO.	Necesario	7		

	Consentimiento informado y asentimiento de la ley Mila.				
H17	**Registro clínico electrónico del recién nacido:** Debe contener la identificación particular del recién nacido para efectos de medicación, junto con los datos asociados de la madre del RN.	Exigible	N/A		
H18	**Formularios en registro clínico electrónico: Completar formularios y/o cuestionarios por el profesional autorizado:** El sistema debe permitir abrir el formulario de registro clínico asociado al episodio actual, de acuerdo con la plantilla. Formularios con registro parametrizable con reporte y visualización de la aplicación.	Necesario	7		
H19	**Registro de atención clínica en ficha por profesional médico, evolución diaria y generación de epicrisis:** El sistema permite el registro de atención por profesional médico. Permite registrar los siguientes parámetros: • Evaluación diaria o por cada visita al paciente. • Registro de signos vitales y/o monitoreo con equipos médicos. • Registrar los diagnósticos del paciente. • Generación de solicitudes de procedimientos. • Generación de ordenes de atención. • Generación de ordenes de exámenes • Generación de solicitud de intervención quirúrgica • Generación de solicitud de traslado (en el mismo establecimiento u otro centro) • Generación de consentimientos informados. • Generación de Interconsultas en sala por especialidad médica. • Indicación de recetas médicas farmacológicas. • Indicaciones de tratamiento terapéutico y/ diagnósticos. • Indicar plan de tratamiento con tareas, ordenes o solicitudes para otros profesionales de la salud, asociados a la atención del paciente.	Necesario	7		

	• Indicación de tratamiento o terapias por los servicios de apoyo clínico (medicina y rehabilitación, medicina transfusional, alimentación, diálisis, UPA) • Realización de epicrisis, incorporando los datos mínimos de las epicrisis según ley 20.584 de derechos y deberes. Rellenar informe de egreso hospitalario.				
H20	**Generación y resultado de las ordenes de atención para unidades de apoyo clínico:** Generación de orden de atención (OA) y resultados integrados al registro clínico del paciente. El sistema debe tener un mantenedor de Ordenes de Atención, las cuales debe permitir la gestión de las solicitudes para dejar constancia de la derivación de atención o derivación de una prestación.	Necesario	7		
H21	**Generar e integrar resultado de las ordenes de atención para procedimientos e intervenciones quirúrgicas:** El sistema permite generar ordenes de atención tales como: procedimientos o intervenciones quirúrgicas. Debe enviar las ordenes de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor al módulo de lista quirúrgica. Además, debe poder integrar los resultados una vez realizados, tanto los procedimientos como las intervenciones quirúrgicas.	Necesario	7		
H22	**Atención clínica, visualización de un problema de salud:** El sistema debe ofrecer una interfaz gráfica intuitiva de un problema de salud consultado. La visualización debe ser: una línea del tiempo, ordenado con fechas en el tiempo de los episodios y/o eventos asociados a la atención clínica del paciente que correspondan al problema de salud o enfermedad crónica consultada, facilitando su visualización (por ejemplo: enfermedad crónica de un paciente).	Necesario	7		
H23	**Formulación del plan de tratamiento por médico:** El sistema permite registrar las indicaciones, formulación del plan, aplicación de terapia o tratamiento. El médico crea la formulación del plan de tratamiento y el registro de atenciones por la especialidad del médico. El sistema debe permitir al usuario formular el plan de atención y	Exigible	N/A		

	registrar las atenciones con sus tareas designadas a profesionales clínicos.				

H24	**Generación de indicaciones por médico:**
	Se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo.
	Las indicaciones posibles son:
	• Administración de tratamiento farmacológico y/o no farmacológico.
	• Realización de exámenes.
	• Evaluación de un médico consultor.
	• Indicación de intervención quirúrgica.
	• Traslado del paciente a otra unidad clínica, ejemplo: hospitalización domiciliaria del mismo establecimiento de salud.
	• Indicación de procedimientos.
	• **Indicación de egreso, con destino a:**
	  • Domicilio.
	  • Traslado a otro establecimiento de salud pública o privado.
	  • Hospitalización domiciliaria
	  • Paciente fallecido.
		Exigible	N/A		

H25	**Registro clínico: Generación de Receta Médica:** El sistema permite realizar una receta médica en base al arsenal farmacológico con autocompletado de datos administrativos y clínicos previamente recopilados, también permite asociar el diagnóstico correspondiente. El sistema debe realizar la prescripción, dispensación y administración en sus diferentes opciones y presentaciones.	Exigible	N/A		
H26	**Registro de Atención: Generación de Informe Proceso Diagnóstico (IPD) por médico:** El sistema permite crear un Informe de proceso diagnóstico, posterior al ingreso del diagnóstico del paciente GES. Debe crearlo a partir de la plantilla creada y autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Además, permitir el registro de otros datos requeridos y la impresión de este.	Exigible	N/A		
H27	**Registro de atención: Registro de valoración de enfermería:** El sistema debe permitir al profesional clínico, registrar la valoración de enfermería realizada,	Necesario	7		

	incluyendo los datos necesarios, ejemplo: Control de Signos vitales: • Temperatura. • Presión Arterial. • Saturación de oxígeno. • Frecuencia cardíaca. • Glicemia capilar. • Exploración física. • Valoración de riesgo de caída. • Valoración de ulcera por presión. • Valoración de dispositivos invasivos. • Necesidad de aislamiento. • Riesgo de dependencia. Todas las escalas normativas y todas las escalas utilizadas en clínica definidas por la institución: • Escala de Barthel. • SAS. • RASS. • Norton. • Braden. • Confort. • Escala de score de tal. • Score pulmonary. • Score San. • Glasgow. Debe tener monitoreo de signos vitales, equipamientos hemodinámicos, respiratorios. Debe ser rápidamente incorporados y parametrizables.				
H28	**Registro de cuidados e indicaciones ejecutadas por profesional clínico:** El sistema debe permitir registrar las notas clínicas, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente durante la hospitalización, en donde se realizaron los procedimientos acordes al plan de cuidados formulado, indicaciones entregadas o ante eventos inesperados. En cada contacto, es posible ejecutar algunas de las siguientes acciones, por tanto, es necesario capturar un conjunto de datos específicos asociado: • Control de signos vitales básicos y avanzados, hemodinámicos. • Procedimientos de aseo y confort. • Cambio de posición del paciente. • Asistencia en la alimentación. • Asistencia respiratoria, neurológicas, digestivas. • Balance hídrico, control de ingesta.	Necesario	7		

	• Valoración de riesgo de caída del paciente y la prevención correspondiente. • Valoración de riesgo de ulcera por presión del paciente y la prevención correspondiente • Preparación y administración de tratamiento, como fármacos, enemas, hemoderivados, oxigenoterapia, heparina, ventilatorios, nutrición enteral, paraenteral, entre otros (medicamentos, bolos, infusión DVA, sedantes, insulinas). • Evaluación de riesgo dependencia del paciente, determinando la categorización correspondiente, según la normativa vigente. • Barthel de ingreso y egreso con reportería asociada • Entre otros. Preparación del paciente para cirugía, exámenes o procedimientos.				
H29	**Registro de atención: Visualizar las indicaciones.** El sistema debe permitir el despliegue del detalle de una indicación, tarea pendiente, orden de atención. También debe permitir a los distintos profesionales médicos y no médico seleccionar una indicación en particular desde su lista de trabajo y visualizar el detalle correspondiente de acuerdo con sus perfiles y actividades.	Exigible	N/A		
H30	**Registro de evaluación clínica por otros profesionales de la salud:** El sistema permite al profesional de apoyo clínico registrar la evaluación, las notas clínicas y la evolución del paciente, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente durante la hospitalización, en donde se realizó la evaluación clínica para determinar el diagnóstico y su evolución, como también la emisión de las indicaciones necesarias y/o la ejecución de determinados procedimientos. Los datos asociados a evaluación clínica deben tener relación con: • Motivo de consulta • Antecedentes clínicos • Antecedentes familiares y sociales • Mediciones de otros parámetros (hemodinámicos, ventilatorios) • Anamnesis	Necesario	7		

	• Exploración física. • Hipótesis diagnóstica o diagnóstico. • Indicación de fármacos. • Indicación de terapias. • Indicación de tratamiento. • Derivaciones a otros centros. • Solicitudes de interconsultas. Para las indicaciones se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo de acuerdo con la plantilla creada.				
H31	**Aplicar plan de tratamiento por otros profesionales:** El sistema permite visualizar las indicaciones médicas y registrar el usuario (ej.: kinesiólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, tecnólogo médico). Registrar el plan de atención con sus tareas asignadas de acuerdo con la indicación del médico de turno, médico tratante u otro profesional. Además, debe generar lista de trabajo para estos profesionales incluyendo elementos como: • Actividad asistencial requerida. • Horario de indicación. • Horario de realización. • Permitir el registro clínico en el módulo del registro clínico electrónico del paciente. Indicaciones específicas quedando registrado el responsable, fecha, hora de forma gráfica.	Exigible	N/A		
H32	**Indicaciones nuevas post atención clínica, por profesionales asociados a la atención**: El sistema permite al profesional clínico incorporar nuevas indicaciones o modificaciones al plan de cuidados del paciente. El sistema debe permitir mostrar una notificación que el paciente tiene indicaciones anteriores al profesional competente que el paciente tiene nuevas indicaciones agregadas al plan de cuidados, tanto farmacológicas, como no farmacológicas, emitidas por el médico tratante o de turno, durante la evaluación de la evolución del paciente.	Necesario	7		
H33	**Realizar interconsulta por especialidad médicas:** Permitir interconsulta entre los servicios clínicos, durante el proceso de hospitalización de especialista, para completitud de diagnósticos y tratamiento. La Interconsulta debe estar creada en base a una plantilla predefinida, autocompletando los	Necesario	7		

	datos administrativos, y clínicos, previamente recopilados. Permitir también, el registro de otros datos requeridos. Debe generar aviso al especialista en caso de la solicitud de interconsultas internas.				
H34	**Registro de eventos de excepción:** Permite registrar un evento de excepción antes del alta correspondiente, como, por ejemplo: abandono o fallecimiento del paciente, alta voluntaria, indicando en la nota clínica de hospitalización la situación ocurrida con la fecha/hora del evento, archivando los datos en el registro clínico del paciente, por perfil de profesional autorizado.	Necesario	2		
H35	**Mantenedor de interconsultas, Gestor de Interconsultas:** El sistema debe tener un mantenedor de solicitud de interconsultas internas (SIC), que informe al especialista mediante una alarma, la existencia de una solicitud de la evaluación del especialista , indicando nombre paciente, ubicación, motivo de solicitud, posibilidad de responder en esa solicitud, solo debe mostrar y permitir contestar la SIC solo a ese profesional con esa especialidad solicitada, además debe permitir crear un mapa de derivación de SIC interna, lo que permite la habilitación o deshabilitar especialidades para que no sean interconsultadas.	Necesario	7		
H36	**Gestión de Atención: Mantenedor de interconsulta de especialidad al alta hospitalizado:** El sistema debe tener un mantenedor de solicitud de interconsultas (SIC) externas, que permita generar un mapa de derivación externas, que permitirá habilitar o deshabilitar especialidades médicas que pueden ser interconsultadas. Debe cumplir con el proceso de referencia y contrarreferencia, tanto para especialidades como para GES. Creando listas de trabajos y seguimiento para la gestión de las solicitudes que son complementaria al Registro Clínico electrónico.	Necesario	7		
H37	**Gestión de alta del paciente por el médico:** El sistema permite generar documento donde el médico pueda registrar y en formato imprimible una alta médica que contemple la epicrisis y egreso hospitalario. Tiene que incorporar el informe de traslado y resumen de traslado, para	Necesario	4		

	el registro de datos y la posterior impresión, los datos serán suministrados por la unidad.				
H38	**Gestión de alta de paciente para hospitalización domiciliaria:** El sistema debe permitir generar una alta médica, con una solicitud de interconsulta en sala de hospitalización, para que se genere un cupo.	Necesario	4		
H39	**Gestión de alta, registro y egreso por profesionales clínicos:** El sistema permite generar documento donde el profesional pueda registrar y en formato imprimible el documento de Egreso del servicio clínico. Tiene que incorporar el informe de traslado y resumen de traslado, para el registro de datos y la posterior impresión de los documentos con los datos suministrados por la unidad.	Necesario	4		
H40	**Generar alta administrativa:** El sistema permite generar alta administrativa, siempre que el médico y profesional hayan realizado sus egresos. En el sistema debe aparecer el alta del paciente, liberando así el cupo de cama.	Exigible	N/A		
H41	**Gestión de atención, almacenar información clínica:** Almacenamiento de un documento electrónico. El sistema permite guardar en el Repositorio Documental definido, cualquier documento creado en esta atención.	Exigible	N/A		
H42	**Gestión de la Atención: Impresión de un documento electrónico**: El sistema debe permitir imprimir cualquier documento creado en esta atención y episodio.	Exigible	N/A		
H43	**Gestión de la Atención: Adjunto de un documento electrónico**: El sistema debe permitir adjuntar cualquier documento escaneado en la atención, en los diferentes tiempos de atención en el registro clínico electrónico. Gestor documento transversal, donde el documento queda disponible para cualquier consulta y asociado a un episodio.	Exigible	N/A		
H44	**Generación de documentos asociados o usados en la atención clínica:** Debe permitir crear un documento de consentimiento informado para distintos usos, ejemplo: cirugías o procedimientos, en base a la plantilla creado, auto- completando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Formularios de impresión y RCE de constancia, con reportería de datos de paciente, información predefinida	Exigible	N/A		

	de información y texto parametrizable de diagnóstico, procedimiento o intervención quirúrgica y otros.				
H45	**Gestión Estadística, Generación del informe Estadístico de egresos hospitalarios por rol autorizado:** Debe permitir crear el informe estadístico de egresos hospitalarios, en base a una plantilla definida acorde a la normativa vigente, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Debe ser por rol correspondiente, debe verificar y registrar la entrega de los datos mínimos básicos exigidos por la normativa.	Exigible	N/A		

5.3 Hospitalización Domiciliaria

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
HD01	**Mapa de cupos de Hospitalización Domiciliaria**: El sistema debe generar mapa de cupos disponibles y modificables para hospitalización Domiciliaria.	Necesario	7		
HD02	**Visualización de mapa de cupos:** Debe existir una visualización del servicio, por sus cupos disponibles, con las áreas separado por su categorización urbano y rural.	Necesario	7		
HD03	**Visualizar estados de cupos:** Visualizar cupos del servicio, clasificados por su estado (disponible u ocupado).	Necesario	4		
HD04	**Solicitud de Cupos:** Registrar una solicitud de cupo para hospitalización domiciliaria para el alta desde los servicios clínicos emergencia, CAE y hospitalizado.	Necesario	4		
HD05	**Gestión de Solicitudes:** Visualizar la totalidad de las solicitudes de hospitalización domiciliaria generadas a partir de una atención médica de emergencia, ambulatoria o durante una hospitalización, del establecimiento. Que contenga la información de registro clínico y demográfico de los pacientes para obtener los datos necesarios y priorizar las solicitudes.	Necesario	7		
HD06	**Gestión de Solicitudes, Cancelar solicitud:** El sistema debe permitir tener la opción de cancelar una solicitud de hospitalización, mostrando un formulario de confirmación de	Necesario	7		

	solicitud, seleccionando el motivo por el cual cancelara la solicitud y dejar detallado en texto libre las observaciones.				
HD07	**Registro de cupos y camas:** Registrar modificaciones en los cupos para hospitalización Domiciliaria y categorizar diariamente según las normal MINSAL.	Necesario	4		
HD08	**Registro de solicitud de traslado:** El sistema permite registrar una solicitud de traslado de un paciente, de hospitalización domiciliaria a otro servicio dentro del mismo establecimiento, cuando existan razones clínicas o administrativas que así lo requieran (plan de contingencia, protocolos clínicos). Así como registrar una solicitud de cupo para hospitalización domiciliaria del mismo establecimiento, para un paciente en atención de urgencia.	Necesario	4		
HD09	**Visualizar RCE del servicio o unidad derivador:** Acceder a información de registro clínico y demográfico de los pacientes del proceso hospitalizado, de emergencia o ambulatorio, para obtener los datos necesarios y priorizar las solicitudes, al seleccionar un cupo del mapa.	Necesario	4		
HD10	**Registro Ingreso del paciente:** Registrar ingreso médico, incorporando antecedentes clínicos, diagnósticos, anamnesis próxima y remota, examen físico, plan de tratamiento de médico y enfermero(a).	Exigible	N/A		
HD11	**Registro Clínico Electrónico:** Registrar diagnósticos, indicaciones (farmacológicas, laboratorio e imágenes), indicaciones y/o solicitudes clínicas (solicitud de procedimiento, intervención quirúrgica, interconsultas). Registrar alergias y alertas importantes para la toma de decisiones clínicas, por parte de todo el equipo de salud.	Exigible	N/A		
HD12	**Registro clínico por equipo multidisciplinario:** Recepción por parte de Enfermeria y médico. • Registro de atención médico tratante. •Registro de gestión de cuidado enfermera, TENS, kinesiólogo, psicólogo, terapeuta, nutricionista, entre otros. • Ejecución de indicaciones. • Registro de atención equipos multidisciplinarios. • Registro de alta clínica.	Exigible	N/A		

5.4 Funcionalidades Anexas al Módulo de Hospitalizado, UHCIP adulto e infanto adolescente.

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
HPS01	**Generación de orden de hospitalización de psiquiatría:** El sistema permite generar una orden de hospitalización distinta de acuerdo con el origen del ingreso del paciente. • Si el paciente proviene desde la unidad de emergencia o de traslado interno de los servicios clínicos, se debe realizar una solicitud de evaluación por la unidad psiquiatría vinculadas al registro clínico, puede deshacer la solicitud con un campo de fundamento clínico en texto libre. Si el paciente proviene desde la atención ambulatoria unidad de emergencia o red, se debe visualizar los documentos previos: informe médico e informe psicosocial.	Necesario	7		
HPS02	**Ingreso de hospitalización a UHCIP (adulto e infanto adolescente):** El sistema debe generar una pestaña única para el ingreso de salud mental que especifique si el ingreso es voluntario o involuntario. Además, debe permitir adjuntar archivo PDF en el registro clínico electrónico del paciente.	Necesario	7		
HPS03	**Visualización de mapa de piso UHCIP (adulto e infanto adolescente):** Desplegar el mapa de piso (camas) de un servicio clínico de hospitalización correspondiente a la fecha actual. El Sistema debe mostrar el mapa de piso (camas) con fecha actual, con las diferentes secciones de Infanto-adolescente y adultos por separados. Cada cama debe estar en forma visiblemente distinguible, y su etiqueta de ocupada, bloqueada, tipo de cama, entre otras. Para las camas programadas u ocupadas con paciente, el Sistema debe mostrar un resumen que sirva para la toma de decisiones o	Exigible	N/A		

	gestión necesaria, por ejemplo: datos personales del paciente, fecha de inicio de hospitalización, fecha de término programada, riesgo de dependencia, alertas de trabajo, cuando se cumple el tiempo para la ejecución de una actividad asistencial en particular.				
HPS04	**Hospitalización Psiquiatría Corta Estadía: Ingreso por el equipo clínico:** El sistema permite que, al ingresar al paciente al servicio, se puedan rellenar los documentos propios de salud mental, por lo tanto, deben estar disponibles los siguientes, por rol autorizado: • Ingreso médico a unidad hospitalizado cuidados intensivos psiquiátricos (UHCIP) (adulto e infanto adolescente. • Pauta de ingreso de ingreso terapia ocupacional y psicología unidad hospitalizado cuidados intensivos psiquiátricos (UHCIP), adultos. • Evaluación ingreso psicosocial. • Informe social (trabajadora social). • Plan de tratamiento integral. • Pauta registro contención física unidad hospitalizado cuidados intensivos psiquiátricos (UHCIP). • Proceso diagnóstico integral. Otros que la unidad estime pertinente.	Necesario	7		
HPS05	**Registro Clínico Electrónico:** Registro de atención clínica y/o procedimientos, pautas, realizados en la atención. El sistema permite registrar antecedentes de psicometría, psicodiagnóstico y realizar cuestionarios normados asociados al programa (contrato terapéutico, consentimiento informado, contrarreferencia) y otros propios de la unidad. • Plan de tratamiento integral por el equipo (terapeuta ocupacional, trabajadora social, psicología). • Registro de reunión de referencia y contrarreferencia.	Exigible	N/A		

	• Registro de asistencia a talleres (por pacientes). • Plan de tratamiento individual de terapeuta ocupacional. • Plan de tratamiento individual de Psicología. • Acuerdo terapéutico. El registro de dichos procedimientos y/ o formularios debe quedar registrado en ficha clínica del paciente por profesional que ejecuto la prestación o intervención.				
HPS06	**Hospitalización Psiquiatría Corta Estadía: Denegación de la hospitalización**: Permite registrar denegación o revocamiento en caso de que el paciente o tutor rechace la hospitalización, salvo ingreso involuntario.	Exigible	N/A		

6 Lista de Espera

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
LES01	**Lista de espera/ Lista de Trabajo:** Debe permitir lista de trabajo para todas las listas de espera, con filtros por especialidad y origen (emergencia, ambulatorio y hospitalizado): • Lista de espera de interconsultas médicas y odontológicas internas del establecimiento. • Lista de espera Intervención Quirúrgica. • Lista de espera GES. • Lista de espera de Controles. • Lista de espera de Procedimientos. • Lista de espera de Interconsultas médicas y odontológicas externas. • Lista de espera de interconsultas a especialidades no médica.	Necesario	7		
LES02	**Visualización de Lista de Espera:** Permitir la visualización de la Lista de espera como lista de trabajo, con los campos necesarios para el establecimiento, como, por ejemplo: especialidad, tiempo de espera, entre otros, permitiendo el filtrado por los parámetros como: estado de la solicitud, rango de fecha, estado actual, identificación del paciente, entre otros. Siendo la visualización en una sola ventana.	Necesario	4		
LES03	**Citas de pacientes:** Permite agendar citas para los pacientes desde las diferentes listas de esperas, la asignación de cita y vinculación a solicitudes de interconsultas, y la cancelación de estas con respectiva causal.	Exigible	N/A		
LES04	**Cambios de Solicitudes Lista de Espera:** Permitir cambiar los tipos de estado, por ejemplo: Inicial, esperando, agendado, egresado, inubicable.	Exigible	N/A		
LES05	**Observaciones:** Permitir la existencia de un campo de observaciones, donde permita registrar en texto libre los	Necesario	4		

	comentarios del administrativo. Debe mostrar el comentario, fecha/hora del registro, y nombre de la persona que lo escribió.				
LES06	**Búsqueda de Solicitudes:** Permitir la búsqueda de Solicitudes por filtro: Nombre apellido paciente, fechas, especialidad, RUN, fecha de ingreso, procedencia, estado de la solicitud, entre otros.	Exigible	N/A		
LES07	**Extracción de Informes:** Permitir extraer informes en base a lo establecido por norma de lista de espera.	Necesario	2		
LES08	**Visualización de Solicitud de Interconsulta:** El sistema debe permitir que todas las solicitudes de interconsulta (SIC) deben estar asociadas al RUN, DNI, pasaporte, entre otros.	Exigible	N/A		
LES09	**Lista de espera/Consulta Nueva/ Solicitud de interconsulta:** Permitir que las consultas nuevas siempre deben estar asociadas a una SIC. No debe permitir agendamientos espontáneos.	Exigible	N/A		
LES10	**Solicitud de Interconsulta:** Las SIC solamente se pueda citar a la especialidad derivada y no ser utilizada para otras especialidades.	Exigible	N/A		
LES11	**Solicitud de Interconsulta:** El sistema no debe permitir duplicidad de las SIC derivadas para la misma patología y especialidad mientras la otra interconsulta se encuentra en estado inicial.	Exigible	N/A		
LES12	**Interconsulta GES:** Permitir que para aquellas interconsultas que sean GES, debe existir una alerta indicándolo, permitiendo la actualización de nuevos problemas de salud.	Exigible	N/A		
LES13	**GES:** Permitir editar estado GES del paciente según edad.	Necesario	2		
LES14	**Lista de Espera Quirúrgica:** Permitir que en la lista de espera de intervención quirúrgica se refleje el motivo y observaciones de las suspensiones ingresadas, además de que permita ingresar más observaciones desde lista de espera.	Necesario	4		
LES15	**Lista de Espera Quirúrgica:** Permitir el ingreso de solicitudes quirúrgicas y SIC para poder realizar carga de pacientes con mayor tiempo de espera.	Necesario	4		
LES16	**Reporte:** Debe entregar reporte de todos los pacientes en egreso de lista de espera ya mencionadas, filtradas	Necesario	4		

	con datos, como, por ejemplo: fecha de estado de lista de espera entre otras. En base a lo establecido por el establecimiento.				
LES17	**Mapa de Derivación:** Debe existir mapa con su mantenedor para la derivación de interconsultas internas de lista de espera entre las diferentes especialidades del hospital. (Debe considerar reportería).	Exigible	N/A		
LES18	**Reporte:** Permitir reporte de pacientes atendidos en los distintos servicios o unidades de atención (urgencia, pabellón, consultorio adosado a especialidad, hospitalizado); debe considerar los datos demográficos del paciente, diagnóstico, ges o no ges).	Necesario	4		
LES19	**Cartas Certificadas:** Permitir que exista la posibilidad de generar las cartas certificadas asociadas a las solicitudes de interconsulta (SIC) del paciente con los datos cargados automáticamente del paciente: nombre, RUN, dirección.	Exigible	N/A		
LES20	**Solicitud de Interconsulta:** Debe existir una opción en las SIC para aquellos pacientes inubicables e indicar que se envió cartas certificada.	Necesario	4		
LES21	**Lista de Trabajo:** El sistema debe permitir un campo en la lista de trabajo donde indique la cantidad de veces en las que el paciente no se presenta (NSP) a su atención.	Exigible	N/A		
LES22	**Solicitud de Interconsulta:** Permitir reporte en determinados rangos de fecha según distintos estados de gestión y egreso de las listas.	Necesario	2		
LES23	**Interconsulta:** No permitir la creación de interconsultas sin: dirección, teléfono de contacto, fundamento diagnóstico.	Exigible	N/A		
LES24	**Registro de contactabilidad:** Permitir el registro de contactabilidad, que tenga un campo obligatorio que enlace la gestión de la lista de espera con el número telefónico de contacto del usuario, fecha y hora para verificar las llamadas efectivas.	Necesario	4		
LES25	**Interconsulta:** No permitir cambios en evoluciones una vez guardada la interconsulta.	Necesario	2		
LES26	**Registro de Fecha y hora:** Permitir registro de hora y fecha de ingreso del registro clínico, el sistema no debe permitir modificación como lo es editar o eliminar el registro clínico una vez	Necesario	4		

	generado. Una vez que se ha grabado un registro clínico, en el caso de existir un error de digitación, que exista la opción de corregirlo con un nuevo registro con la hora correspondiente a este nuevo y relacionarlo con el registro anterior que no ha sido eliminado.				
LES27	**Visualización:** Permitir visualizar la totalidad de episodios y atenciones que ha tenido el paciente en la institución, sin tener que salir de la plataforma para volver a ingresar.	Necesario	2		
LES28	**Gestión de la Demanda- Lista de Espera Quirúrgica:** Permitir visualizar la lista de espera quirúrgica centralizada, en una lista de trabajo gestionable, por especialidad y según normativa de lista de espera (LE) vigente. Además, contemplar la distinción GES.	Necesario	2		
LES29	**Emitir reporte de listas de esperas:** El sistema debe emitir reporte de solicitudes de interconsultas generadas con sus diferentes estados, según normativa vigente y formato establecido, la cual debe incluir todos los datos que se registran en la lista de espera. Debe poder ser filtrada como, por ejemplo: rango de fecha y estado de lista de espera, entre otras, o los que sean solicitados por el establecimiento hospitalario.	Necesario	4		
LES30	**Lista de Trabajo:** Permitir visualizar lista de trabajo que permita gestionar el proceso de contactabilidad y mantener el registro de las acciones generadas para cada gestión (observaciones de llamados, egresos, envío de cartas). • Lista de espera de interconsultas médicas y odontológicas internas del establecimiento. • Lista de espera intervención quirúrgica. • Lista de espera GES. • Lista de espera de controles. • Lista de espera de procedimientos. • Lista de espera de interconsultas médicas y odontológicas externas. • Lista de espera de interconsultas a especialidades no médicas.	Necesario	7		
LES31	**Lista de Espera:** Permitir la visualización de solicitud de interconsulta (SIC) ordenadas de acuerdo con la priorización	Necesario	7		

	definida, permitiendo la extracción de todos los datos de la SIC. Debe permitir la extracción de lista de espera del establecimiento, respondiendo al formato para entrega al MINSAL (Repositorio Nacional de Lista de Espera).				
LES32	**Orden de atención:** Debe permitir crear una orden de atención (OA) GES y no GES, en base a la plantilla creada, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Además, permitir el registro de otros datos requeridos.	Necesario	4		
LES33	**Reporte listas de espera:** Debe permitir un reporte de listas de espera de controles y procedimientos que incorpore el diagnóstico confirmado por el especialista. Informe con nómina y listas de espera de procedimientos por procedimiento; por ejemplo: endoscopía, colonoscopía, ecocardiograma, entre otros.	Necesario	7		

7 Proceso Atención Ambulatoria

7.1 Referencia y Contrarreferencia/ Gestión de la Demanda- Atención Ambulatoria de Especialidades

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
ERC01	**Interconsultas:** Permitir la recepción de la referencia mediante interoperabilidad e integración desde las diferentes procedencias, trazabilidad de tiempos fecha-hora desde la etapa inicial, administración y gestión de interconsultas generadas desde los distintos niveles de atención de la red asistencial, enmarcada en norma 118. La solicitud de interconsulta (SIC), se presenta en base a la planilla creada, autocompletando los datos administrativos y clínicos previamente recopilados. Además, permite el registro de otros datos requeridos.	Exigible	N/A		
ERC02	**Solicitud de Interconsulta:** En revisión de solicitud de interconsultas (SIC), recibidas desde los distintos orígenes, el usuario podrá evaluar la pertinencia con sus campos respectivos, y notificar al origen las observaciones de la no pertinencia tanto como los de pertinentes con su prioridad.	Exigible	N/A		
ERC03	**Interconsulta:** Para la gestión de interconsultas el sistema debe permitir la función y figura de Médico contralor, para revisión de las solicitudes por profesional para validar y garantizar la pertinencia y priorización de la solicitud de Interconsulta para nueva consulta de especialidad. En revisión de solicitud de interconsultas (SIC) emitidas el usuario autorizado debe poder administrar las derivaciones: • Evaluar y determinar pertinencia de interconsulta:" Pertinente" o "No Pertinente". En caso de ser "No Pertinente", debe solicitar el registro del fundamento y marcar "egreso". • Determinar la priorización de interconsulta (alta, mediana y baja).	Exigible	N/A		

	• Permitir crear solicitud exámenes, procedimientos u otros en interconsultas pertinentes. • Permitir registrar observaciones generales a solicitudes de interconsulta pertinentes. • redirecciona a programas de resolutividad del centro de salud que correspondan.				
ERC04	**Visualización DAU (Dato de Atención Urgencia):** El sistema permite la visualización y aceptación de la interconsulta desde el servicio de urgencias, la cual puede ser enviada por dos caminos: • Manual: debe permitir el ingreso o registro de estas interconsultas en el sistema. • Sistema: en caso de que sea a través del sistema debe permitir mediante una interfaz de usuario la asignación de selección de prioridad. Debe mostrar/visualizar un listado de los pacientes en base a su categorización.	Necesario	7		
ERC05	**Reportes:** El sistema permite la creación de un reporte de los pacientes que han sido enviados mediante interconsulta a atención ambulatoria de especialidad.	Necesario	2		
ERC06	**Contrarreferencia:** Permite crear informe clínico de contrarreferencia que incluya una copia de la primera atención y/o el último registro clínico desde la especialidad, para notificación al centro de origen del paciente.	Exigible	N/A		
ERC07	**Reporte de referencia/contrarreferencia:** Tiene que permitir generar un reporte con un listado de pacientes que muestre los registros de consulta nueva y al alta, que están asociadas a una contrarreferencia.	Exigible	N/A		

7.2 Atención Ambulatoria de Especialidad

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		

AAE01	**Recepción del paciente:** El sistema tiene que permitir registrar la fecha- hora de llegada del paciente a la atención.	Exigible	N/A		
AAE02	**Visualización de datos:** Permite desplegar datos de identificación del paciente.	Exigible	N/A		
AAE03	**Confirmación entrada a box:** Permitir el registro de confirmación de entrada del paciente al box, mediante una acción ejecutada por el profesional médico o no médico, indicando fecha-hora de entrada.	Exigible	N/A		
AAE04	**Visualización de ficha:** Permitir visualización en la ficha del paciente, episodios de acuerdo con estructura línea de tiempo cronológico, que muestre los registros clínicos anteriores y actuales por especialidad, como en otros módulos o componentes del ciclo de atención del paciente. (incluyendo visualización de documentos, procedimientos, exámenes incorporados en esta línea de tiempo de los episodios) de acuerdo con la especialidad y profesional correspondiente.	Exigible	N/A		
AAE05	**Registro clínico:** El sistema debe permitir registro clínico (con estructura SOAP): motivo, anamnesis, exploración, diagnósticos e indicaciones.	Exigible	N/A		
AAE06	**Visualización:** Permite en el proceso de atención, visualizar en una sola ventana la totalidad de los recursos disponibles, RCE, diagnósticos, formularios, medicamentos, imágenes, indicaciones, orden atenciones, especialidad, interconsultas, licencias médicas, procedimientos, documentos de informes complementarios. Permite visualizar las atenciones anteriores de estos recursos, como la atención actual.	Exigible	N/A		
AAE07	**Consulta nueva:** El sistema permite crear una consulta nueva de especialidad (Ingreso): La primera atención generada por un episodio de una patología, en donde se puede o no dar resolución a un problema de salud. Cada primera atención de un paciente, generada por una interconsulta es una consulta nueva por la especialidad que realiza la atención, independiente que el paciente haya sido atendido en otra ocasión en la especialidad. En esta actividad el especialista evaluará el ingreso a la especialidad según la pertinencia,	Exigible	N/A		

	de acuerdo con los criterios de referencia previamente definido.				
AAE08	**Valoración clínica:** Registro de valoración clínica por el personal autorizado, de acuerdo con el tipo de atención o actividad asistencial a realizar, el sistema debe permitir al personal médico, registrar el control de signos vitales, antropométricos y otros parámetros, incluyendo datos como: peso, talla, temperatura, presión arterial, saturación O2, frecuencia cardiaca.	Exigible	N/A		
AAE09	**Formularios de registro clínico:** Despliegue del formulario de registro clínico según el tipo de atención o actividad asistencial a realizar por profesional medico y/o no médico. De acuerdo con la selección del paciente, el sistema permite abrir el formulario de registro clínico, conforme al tipo de atención a realizar, por ejemplo: preparación del paciente, consulta/control de especialista, atención kinesiológica, rehabilitación, diálisis, entre otros. Además, el sistema debe autocompletar los datos clínicos recopilados en las etapas anteriores.	Necesario	4		
AAE10	**Atención asistencial:** De acuerdo con el tipo de atención o actividad asistencial a realizar, el sistema debe permitir al profesional competente (ejemplo: Médico, Odontólogo, Profesionales de Matronería, Fonoaudiólogo, Psicólogos, Enfermero, Tecnólogo Médico, Terapeuta Ocupacional, Kinesiólogo, Asistente Social, Nutricionista, entre otros profesionales), registrar las notas clínicas, indicaciones necesarias y ejecución de procedimientos requeridos. Los datos asociados a evaluación clínica deben tener relación con: • Motivo de consulta. • Antecedentes clínicos. • Antecedentes familiares y sociales. • Anamnesis. • Examen físico. • Hipótesis diagnóstica y/o diagnóstico. Indicaciones.	Exigible	N/A		
AAE11	**Diagnósticos favoritos:** Permite en el proceso de atención la disponibilidad de diagnósticos de uso recurrentes o favoritos por profesional, especialidad o estamento.	Exigible	N/A		

AAE12	**Plan de tratamiento:** De acuerdo con el tipo de atención o actividad asistencial a realizar, permitir al profesional competente formular el plan de atención para el paciente, de acuerdo con la indicación entregada, por ejemplo: cirugía, procedimientos, curaciones, rehabilitación, atención kinesiológica, diálisis, entre otras.	Necesario	7		
AAE13	**Generación de formularios:** Permitir generar de forma automática los formularios de: GES, IPD, Notificación de su enfermedad GES, consentimientos informados, y otros que pudieran ser adjuntados posteriormente, quedando estos adicionados a la ficha clínica permitiendo su impresión.	Exigible	N/A		
AAE14	**Adjuntar e imprimir documentos:** Permitir imprimir cualquier documento creado (PDF) en la atención al paciente, como también adjuntar cualquier documento escaneado en dicha atención, según formato definido por la institución.	Exigible	N/A		
AAE15	**Generación de indicaciones:** El sistema debe permitir la generación de indicaciones, permitiendo el registro de un conjunto de datos específicos según tipo. Las indicaciones posibles son: • Indicación de tratamiento farmacológico o no farmacológico, con emisión de las recetas médicas. • Lista de tareas (indicación de exámenes de laboratorio, imagenología u otros). • Ordenes de atención (Indicación de hospitalización, pabellón, procedimientos). • Consentimientos informados (indicación de cirugía, Procedimientos, entre otros). • Derivación a otro especialista u otro establecimiento de salud mediante interconsulta en el sistema. • Derivación a Unidad de Emergencias. Indicación de control (con tiempo 7 días, 15 días, 30 días, 3 meses, entre otros, con la finalidad de extraer por tiempo la lista de espera control.	Necesario	7		
AAE16	**Generación de recetas:**	Exigible	N/A		

	Permitir generación de una receta para el paciente que es atendido, la cual debe quedar inmediatamente disponible en el módulo de Farmacia para ser despachada. Considerar las siguientes alertas al momento de generar receta: Alergias, Reacciones Adversas a Medicamentos, Medicamentos controlados, Medicamento no disponible, medicamentos indicados en recetas anteriores y restricciones según arsenal farmacológico. Permitir incluir diagnóstico de la patología, condición (Morbilidad, Crónico, GES, Arsenal de medicamentos, dosis de medicamentos, presentación del medicamento, frecuencia y repeticiones, indicando también la fecha de indicación).				
AAE17	**Solicitud de intervención quirúrgica:** Desde consultorio adosado a especialidad debe permitir solicitud de Intervención quirúrgica que es normativo, por medio del consentimiento informado, para ingreso a lista de espera de intervenciones y procedimientos, con codificación según arancel de Fonasa, plano, lateralidad y tipo de priorizaciones y si es GES, según corresponda.	Exigible	N/A		
AAE18	**Solicitud de exámenes complementarios:** Permite generar una orden través de solicitudes de exámenes complementarios de imagenología, procedimientos diagnósticos, exámenes de laboratorio - toma de muestra, procedimientos de Matronería, procedimientos diagnósticos de anatomía patológica de biopsias y procedimientos de enfermería, que generen lista de tareas o espera en cada área según donde corresponda la prestación solicitada, definida por el establecimiento.	Exigible	N/A		
AAE19	**Registro de pertinencia en box clínico:** Permitir el registro de pertinencia en box clínico de la atención en consulta nueva, por el profesional teniendo un icono obligatorio, posterior a la atención del paciente.	Exigible	N/A		
AAE20	**Emisión de contrarreferencia:** El sistema debe permitir la emisión de una contrarreferencia a pacientes dados de alta de especialidad, y así permitir la	Exigible	N/A		

	integración con APS para su notificación y recepción. Solo aplica en caso de que la factibilidad técnica de interoperabilidad y/o integración para la clasificación de esta como exigible.				
AAE21	**Atención teleconsulta:** Permitir la incorporación como actividad de atención de pacientes, la Teleconsulta, que consiste en la atención directa con pacientes utilizando un canal que permita la atención remota, y que cuente con requisitos de privacidad HIPAA.	Necesario	7		
AAE22	**Atención teleconsulta:** Permitir a Teleconsulta y teleconsultoria cumplir con los mismos estándares de la consulta presencial, por lo tanto, se requiere que tenga accesos a RCE, a la generación de órdenes de laboratorio, recetas, procedimientos, imagenología, realización de interconsultas, referencia y contrarreferencia, permitiendo el llenado e impresión de formularios como IPD, OA, entre otros.	Exigible	N/A		
AAE23	**Contabilización de tiempos:** Permitir contabilizar tiempos de atención del paciente: recepción, espera, inicio, fin de la atención clínica o procedimiento, tiempos medios de atención, tiempos muertos y otros indicadores que el establecimiento estime pertinentes.	Necesario	4		
AAE24	**Visualización de atenciones:** El sistema debe permitir seleccionar una atención específica y mostrar un reporte detallado por atención que contiene los datos del paciente, el detalle de las actividades asistenciales realizadas, por ejemplo: consulta médica, procedimiento ejecutado, además, la lista de insumos utilizados de acuerdo con las actividades asistenciales ejecutadas.	Necesario	4		
AAE25	**Controles por especialidad:** El sistema debe permitir la creación de un repositorio de lista de espera de consulta control, para que los pacientes que deben ser citados nuevamente para el control con especialistas sea de acuerdo con la fecha-hora que corresponden.	Exigible	N/A		
AAE26	**Controles por especialidad:** El sistema permite la creación de consulta control, las cuales son atenciones posteriores a la primera consulta por un mismo problema	Exigible	N/A		

	de salud cuya finalidad es completar el estudio, tratamiento y/o seguimiento.				

7.3 Atención Ambulatoria Odontológica

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
AAO01	**Tipos de atenciones:** Permite agendar uno o más de un tipo de atención, siendo los tipos de atención: consulta nueva, ingreso al tratamiento, controles, consulta post alta, consulta nueva con ingreso a tratamiento, ingreso de tratamiento a alta tratamiento, control con alta a tratamiento, consulta nueva con ingreso a tratamiento - alta tratamiento, procedimiento y exámenes radiológicos, indicar las pertinencias según protocolo de atención, pertinencia de condición clínica, caso GES, PPV. Estado de paciente: llegada, atendido, inasistencias (de consulta nueva y de consulta repetida) y altas (término tratamiento, alta integral, alta administrativa).	Exigible	N/A		
AAO02	**Prestaciones:** Permite crear, modificar y eliminar tipos de prestaciones con códigos MAI y actividades de REM de acuerdo con la oferta del hospital.	Necesario	4		
AAO03	**Generación de solicitudes:** Permite generar interconsulta de derivación a especialidades o red asistencial, solicitud de intervención quirúrgica y procedimiento a través del consentimiento informado, solicitud de exámenes.	Exigible	N/A		
AAO04	**Generación de reportes:** El sistema debe permitir la realización, emisión y extracción de bases de datos de atenciones, prestaciones, ingreso, alta, en formato texto plano o csv según se determine, en base a parámetros seleccionados por el usuario o los definidos en los REM.	Necesario	4		
AAO05	**Prestaciones:** Permitir indicar si la prestación y diagnóstico es GES, PPV, PPI, separada por grupo etario y por tiempo de tratamiento.	Necesario	7		
AAO06	**Registro clínico:** Permitir registrar datos clínicos (peso, talla, otros), signos vitales, evaluaciones, antecedentes clínicos, diagnósticos (Presuntivos y Confirmatorios).	Exigible	N/A		

AAO07	**Lista de trabajo:** Permitir seleccionar al paciente desde lista de trabajo de interconsultas pendientes, visualizar interconsultas y antecedentes del paciente.	Necesario	2		
AAO08	**Visualización de indicaciones:** Permitir visualizar resultados o indicaciones médicas realizada, registrar o completar indicaciones farmacológicas, imagenologías, interconsultas, exámenes, procedimientos u otros.	Exigible	N/A		
AAO09	**Odontograma:** Permitir incluir formato tipo odontograma para registro clínico.	Exigible	N/A		
AAO10	**Prestaciones:** Permite identificar las prestaciones realizadas dentro del box de atención o del cupo asignado, con la finalidad de extraer el total de actividades realizadas por el médico.	Necesario	4		

8 Proceso de Atención Unidad de Farmacia

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
FAR01	**Integración e interoperabilidad:** Permitir la integración con sistemas de recaudación, como con los dispensadores semiautomáticos de fármacos e insumos, para la prescripción, despacho y proceso de registro en RCE de pacientes. Permitiendo la integración con los softwares de gestión de farmacia y abastecimiento, para reportar los datos solicitados durante la preparación de receta (stock, número de lote y fecha de vencimiento). Para procesos de atención abierta, cerrada y unidad de emergencia. Solicitud de fármacos a su respectiva bodega, en base a los stocks mínimos definidos para cada producto. Esta solicitud podrá ser consultada a través de informes u otro mecanismo. Posibilidad de trabajar con punto de reposición.	Exigible	N/A		
FAR02	**Farmacia atención abierta:** Permitir registrar los datos esenciales del medicamento o insumo (número de lote, fechas de recepción, salida, vencimiento.), para asegurar la trazabilidad del producto en todo momento desde su ingreso a la farmacia hasta su entrega al paciente.	Exigible	N/A		
FAR03	**Farmacia atención abierta:** **Permitir la gestión y control de fármacos, con sus bodegas de uso interno:** • Tendrá que proveer control, que permita la gestión de farmacia en cuanto al manejo de medicamentos e insumos, como, por ejemplo: inventarios, control de stock mínimo y crítico. • Permitir la rebaja de medicamentos por vencimiento y mermas, se debe considerar una bodega virtual para poder traspasar productos mermados y vencidos, para que permanezcan dentro del registro de la unidad respectiva mientras se aprueba su eliminación, pero que no pertenezca a las bodegas activas de la unidad. • Realizar la actualización automática del stock de	Exigible	N/A		

	productos, tanto con el ingreso a través de nuevos pedidos, devoluciones, préstamos, como con la baja vía despacho a unidades, traspaso, registro de dispensación y mermas. • Permitir identificar medicamentos, por ejemplo: GES, no GES, Ley Ricarte Soto, programas ministeriales, entre otros. • Habilitar la solicitud automática de fármacos a su respectiva bodega, en base a los stocks mínimos definidos para cada producto. Esta solicitud podrá ser consultada a través de informes u otro mecanismo.				
FAR04	**Movimiento de fármacos:** Permitir la comunicación entre farmacia y bodega para gestionar el movimiento de fármacos desde una a otra, y viceversa (en caso de devoluciones). • Realizar actualización en línea de los movimientos de los productos, tanto con el ingreso a través de nuevos pedidos, devoluciones, préstamos, como con la baja vía despacho a unidades, traspaso, registro de dispensación y mermas. • Generar traspaso y devoluciones entre bodegas de farmacia, bodegas de centro y bodega central. • Permitir el manejo de múltiples bodegas y múltiples usuarios en ellas. • Definir stock mínimo y crítico en el establecimiento. • Realizar la actualización automática del stock de productos, tanto con el ingreso a través de nuevos pedidos, devoluciones, préstamos, como con la baja vía despacho a unidades, traspaso, registro de dispensación y mermas. Informe consulta gasto (cantidad y precio por paciente).	Necesario	7		
FAR05	**Reportería:** Permitir generar reportes e informes relacionados con el seguimiento de medicamentos:	Necesario	7		

	• Reporte de recetas despachadas de forma oportuna y completa, que incorpore: nombre, RUN, diagnóstico, ID receta, listado de medicamentos, otros. • Reportes REM relacionados con servicios farmacéuticos. • Reporte consulta de despachos a pacientes crónicos, medicamento y código de diagnóstico. • Registro electrónico de productos sujetos a control legal, de acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de sustituir el registro manual. • Reporte consulta de despachos a pacientes crónicos, medicamento y código de diagnóstico. • Reporte consulta de medicamentos controlados. • Reporte consulta histórica de recetas por cada profesional. • Reporte de recetas despachadas incompletas y N.º prescripciones no despachadas. • Reporte consulta de perfil fármaco- terapéutico por paciente. • Consulta y reporte de recetas y prescripciones con sus valores desagregados, por rango de fechas. • Informe consolidado de medicamentos retirados por rango de fecha. • El sistema permite la consulta histórica de medicamentos despachados por pacientes e historial de pacientes atendidos con medicamentos ordenados por orden de fechas y filtrados por programas, tipos de recetas, patologías GES, pacientes de alta, y por rango de fechas. • Reporte de consulta de despacho de medicamentos por paciente a Farmacia atención abierta, atención cerrada y unidad de emergencia.				

	• Consulta y reporte de pacientes atendidos en el mes, ordenados por patología. • Informe consulta listado de medicamentos solicitados no despachados, por fecha de vencimiento. • Informe consulta de promedio de prescripciones por recetas por farmacia dispensadora y cálculo promedio del gasto por receta. • Consumo histórico de fármacos por farmacia en rango de fechas. • Informe fármacos por farmacia en stock crítico, punto pedido, por fecha vencimiento. • Informe por médico, correlativo de N.º de recetarios entregados por farmacia para el control de números de recetas digitales y manuales, con sus respectivas consultas e informes. • Informe REM farmacia. • Informe de retiros de medicamentos programados. • Informe de recetas digitadas/despachadas/preparadas por operador entre fechas. Permitir generar reportes de despacho de medicamentos asociados a área geográfica.				
FAR06	**Reportería:** Permitir generar reportes e informes relacionados con seguimiento de medicamentos tales como: • Consulta, alerta y reporte de pacientes con medicamentos pendientes, permitiendo emitir tal documento para ser entregado a cada paciente que cuente con medicamentos pendientes pertenecientes a su receta. • Reporte de informe de pacientes asociados a patologías GES y no GES, con retiro de medicamentos despachados pertenecientes a GES y no GES. • Estadísticas consolidadas de prestaciones y a pacientes GES, considerando código trazador de Fonasa.	Necesario	7		

	• Reporte de medicamentos pendientes de entrega hacia el paciente por parte de farmacia, considerar que el siguiente reporte es obligatorio bajo normativa ministerial. • Informe de recetas validadas por Químico Farmacéutico. Permitir generar reportes e informes relacionados con el seguimiento ayudas técnicas y órtesis.				
FAR07	**Validación de receta médica:** Permitir sugerencia de la prescripción de acuerdo con indicaciones del médico tratante por parte de Químico Farmacéutico, ante errores o incongruencias médicas tras prescripción.	Exigible	N/A		
FAR08	**Farmacia atención abierta:** Permitir restringir la prescripción solo a medicamentos asociados al arsenal terapéutico. También deberá restringir la prescripción asociada al diagnóstico. Por otro lado, permitirá una vez que se genere la prescripción separar las recetas por los diferentes programas y especialidades.	Exigible	N/A		
FAR09	**Perfil farmacoterapéutico:** Gestionar hojas de perfil farmacoterapéutico para la administración de medicamentos: Visualizar prescripción por calendarización, horarios, por paciente o grupos de pacientes.	Necesario	7		
FAR10	**Registro y visualización de indicaciones:** Registrar y visualizar la indicación y la administración de medicamentos a los pacientes, realizados en los servicios clínicos o unidades de apoyo. Debe contemplar fecha, hora, nombre, apellido y profesión de quien realiza la administración.	Necesario	4		
FAR11	**Prescripción (atención abierta):** El sistema permite generar notificación emergente cuando el médico prescriba un fármaco perteneciente a canasta básica de APS. Pudiendo bajo criterio médico, designar su prescripción en nuestras dependencias o en CESFAM al que pertenece dicho paciente. Debería disponerse de un reporte que indique los pacientes en control en el hospital que solo tienen indicación de fármacos de APS.	Necesario	4		
FAR12	**Prescripción:** Generación de receta electrónica y física de acuerdo con el formato de la institución, diferenciando: • Recetas magistrales. • Receta cheque. • Formato especial para receta retenida.	Necesario	7		

	• Formato especial para fármacos de uso restringido (PUR). Crónica, morbilidad, tratamiento hospitalización, altas, Urgencia. • Receta reposición de stock. • Compra ocasional (Formulario n°3). Y en todos los formatos deseables por el establecimiento.				
FAR13	**Prescripción:** Las indicaciones médicas se deben generar en base a la dosis requerida según la unidad de medida correspondiente (x ej.: mg, mcg, UI.), y también en base a la presentación (Por Ej: cápsulas, comprimidos, papelillo, jarabe, solución inyectable, matraz), intervalo de administración, cantidad de repeticiones y fecha de próximo despacho. Debe contemplar dosis equivalentes de presentaciones de formas farmacéuticas como líquidas, inhaladores y cremas.	Necesario	7		
FAR14	**Prescripción:** El sistema debe incluir en perfil médico, profesional un módulo, casilla, u otro distintivo único de ingreso de fármacos preparados magistrales, con su gramaje diferenciado y su presentación en papelillo, cápsula entre otros.	Necesario	7		
FAR15	**Validación por magistral:** El sistema debe registrar nombre de medicamento, dosis, serie, número de lote, nombre de químico farmacéutico quién elaboró y validó prescripción.	Necesario	7		
FAR16	**Cálculo de dosis:** Se sistema permitirá realizar en base a la forma farmacéutica el cálculo para sólidos orales, rectales, vaginales, parches. En otros casos, como gotas, soluciones y suspensiones dispensar de acuerdo con volumen total, inhaladores de acuerdo con dosis prescrita (puf e inyectables en números enteros de acuerdo con tablas de conversión (x ej.: Amikacina 500mg/2ml en dosis 750mg/día = 2 ampollas)	Necesario	7		
FAR17	**Prescripción**: Para la emisión de recetas debe considerar sólo profesionales legalmente habilitados para prescribir según código sanitario (médicos, odontólogos, matronas y tecnólogos médicos).	Exigible	N/A		
FAR18	**Prescripción:** Permitir solamente la visualización de recetas para profesionales no habilitados legalmente para prescribir.	Exigible	N/A		
FAR19	**Gestión farmacéutica:** Debe permitir definir, clasificar y restringir arsenales por ámbito (hospitalizado/altas/ambulatorio/urge	Exigible	N/A		

	ncia) y sus especialidades, incluso por diagnóstico (ejemplo: patologías GES). Considerando también servicios de UHCIP adulto e infanto adolescente, unidades de apoyo que atienden pacientes, pabellón, diálisis, entre otros.				
FAR20	**Integración e interoperabilidad:** Integración entre farmacia y sistema de recaudación, para generar cuenta corriente del paciente.	Necesario	7		
FAR21	**Integración e interoperabilidad:** El sistema permite integración con sistema de recetas electrónicas, (como, por ejemplo: APIS).	Exigible	N/A		
FAR22	**Prescripción:** Permitir consultar, modificar y visualizar el arsenal farmacológico del Hospital, validado y disponible.	Exigible	N/A		
FAR23	**Administración registro clínico:** Acceso a visualizar la ficha del paciente en forma transversal, para ver archivo histórico de tratamientos, despachos previos, indicaciones suspendidas y activas.	Exigible	N/A		
FAR24	**Registro manual recetas:** El sistema debe permitir regularizar el registro de recetas físicas, en caso de contingencia cuando el sistema HIS, presente problemas de operatividad para los usuarios involucrados.	Exigible	N/A		
FAR25	**Gestión farmacéutica:** El sistema debe permitir modificar la cantidad a despachar, con opción a describir el motivo en texto libre o lista parametrizable de prescripciones totales o parciales, permitiendo validar prescripciones médicas por parte del perfil de químico farmacéutico o perfil autorizado, para el despacho de recetas, con opción de observaciones que se visualicen en la ficha clínica.	Exigible	N/A		
FAR26	**Gestión farmacéutica:** El sistema debe permitir generar informes y reportes de consumo de medicamentos valorizados, por ejemplo: consumo diario, mensual, anual, medicamentos por paciente, por unidad, servicio clínico uso de medicamentos asociados a patologías GES, programas ministeriales y otros.	Exigible	N/A		
FAR27	**Integración e interoperabilidad:** El sistema HIS debe apoyar al sistema de recaudación para la rebaja automática de stock de acuerdo con los eventos que impliquen administración de fármacos.	Exigible	N/A		
FAR28	**Integración e interoperabilidad:** El sistema debe integrar un módulo de botiquín de unidades externas dependientes de nuestro hospital tales como: CESAM, hemodiálisis, hospitalización domiciliaria, hospital día, policlínico Infanto adolescente. Para despacho de recetas,	Necesario	7		

	contemplando stock mínimo, máximo y crítico para el botiquín.				
FAR29	**Farmacia atención cerrada y atención abierta:** El sistema permite realizar conciliación farmacéutica.	Exigible	N/A		
FAR30	**Despacho:** El sistema debe incluir validación de retiro por parte del paciente con huella dactilar, permitiendo reportaría de: Si paciente retira, o en caso de relación con el paciente para poder validar su retiro, que fármacos retira, (nombre de fármaco, dosis, días de tratamiento) fármacos que queden pendientes en receta emitida y funcionario que despacha medicamento.	Necesario	7		
FAR31	**Despacho**: El sistema debe permitir que, al realizar el despacho de medicamentos, el rol autorizado pueda registrar el nombre, apellido y RUN del responsable que realiza la tarea.	Exigible	N/A		
FAR32	**Despacho:** El sistema debe permitir a TENS de farmacia, visualizar los tratamientos activos e históricos indicados al paciente, separado por especialidad, por medio de búsqueda de RUN del paciente (dentro del módulo farmacia).	Exigible	N/A		
FAR33	**Gestión farmacéutica:** El sistema debe permitir generar reporte de recetas y recetas crónicas previo a la fecha de despacho, que identifique nombre, RUN, edad, servicio/unidad y diagnóstico como mínimo, con el fin de identificar las repeticiones de receta.	Exigible	N/A		
FAR34	**Gestión farmacéutica atención cerrada:** En farmacia de atención cerrada el sistema debe permitir la devolución de fármacos desde los servicios clínicos o unidades de apoyo, asociados a un paciente y/o a un stock de servicio. Llegando a farmacia para ver los estados y poder clasificarlos como vigente y reingresar al stock o como merma.	Necesario	4		
FAR35	**Alerta: Guías farmacológicas:** El sistema debe contar con guías farmacológicas y de consulta, para cada uno de los principios activos, indicando: dosis máxima y mínima, principales interacciones, efectos secundarios, equivalencia en unidad de medida y vías de administración.	Necesario	4		
FAR36	**Alerta: Contar con elementos de seguridad clínica:** Identificación de problemas relacionados con medicamentos mediante alertas, validación por químico farmacéutico al momento de la dispensación y, en caso de que	Necesario	7		

	proceda, registro de administración. Ejemplo: alergias, dosis máxima y mínima (por dosis y por día), interacciones, sinergias, dosis por kg/peso, contraindicaciones a medicamentos o dietas, equivalencia de la dosis en la forma farmacéutica, duración del tratamiento.				
FAR37	**Alertas:** El sistema debe notificar al médico la falta de stock o inexistencia de algún medicamento, al momento de realizar la prescripción.	Exigible	N/A		
FAR38	**Alerta del fármaco en atención cerrada:** Cada medicamento debe considerar todas las vías de administración permitidas, por ejemplo: intraósea, subcutánea, endovenosa, nebulización, aplicación e informar precauciones de administración (modo, velocidad, diluyentes recomendados e incompatibles).	Exigible	N/A		
FAR39	**Prescripción:** El sistema debe permitir la indicación de posología específica para TACO, insulinas o cualquier medicamento que requiera un esquema terapéutico per sé, o de acuerdo con los requerimientos del prescriptor.	Necesario	7		
FAR40	**Administración:** El sistema debe contar con parámetros para farmacovigilancia a través de reportería y lista de trabajo. Considerando formulario para notificar reacciones adversas al medicamento (RAM) desde cualquier ámbito, como lista de trabajo para el químico farmacéutico.	Exigible	N/A		
FAR41	**Gestión farmacéutica:** El sistema debe permitir consultar disponibilidad de medicamentos asociados a diagnósticos, con tiempos de tratamiento definidos.	Necesario	4		
FAR42	**Prescripción:** El sistema debe permitir generar al momento de la prescripción el Formulario N°3: de solicitud de compra de medicamentos especiales. Gestión de prescripciones de fármacos fuera del arsenal o de otro tipo, que requieran de autorizaciones especiales.	Necesario	7		
FAR43	**Prescripción:** El sistema debe permitir realizar dispensación de medicamentos sujetos a control legal en módulo específico con opción de informes y reportes de consumo similares a libro.	Necesario	7		
FAR44	**Prescripción**: El sistema debe permitir generar automáticamente una alerta de receta emitida duplicada por profesionales de diferentes especialidades o de la misma, pero conteniendo uno o más	Exigible	N/A		

	medicamentos duplicados en recetas distintas, en caso de aceptar la alerta debe registra una observación.				
FAR45	**Prescripción:** El sistema debe permitir generar en forma automática un plan de tratamiento fármaco-terapéutico por un periodo de tiempo definido, para atención cerrado y abierta.	Necesario	4		
FAR46	**Administración atención cerrada:** Alerta de medicación retrasada, prescripción modificada, medicamentos no administrados u otra (inicio, modificación, término o suspensión).	Necesario	4		
FAR47	**Prescripción y registro fármacos:** Prescripción y registro de medicamentos que requieran algún documento adicional, como aquellos de uso ocasional, preparados magistrales externos, restringidos según directrices internas y medicamentos sujetos a control legal.	Necesario	4		
FAR48	**Prescripción:** Permite generar una alerta de tipo recordatorio para ingresar de manera manual a sistema PROA a profesional médico, al momento de realizar la prescripción de antimicrobianos restringidos.	Necesario	7		
FAR49	**Registro fármacos externos:** El sistema debe permitir registrar el ingreso de fármacos magistrales, tanto como la validación y dispensación.	Necesario	4		

9 Unidades de Apoyo

9.1 Unidad de Medicina Transfusional

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
UMT01	**Integración con sistema de banco de sangre:** El sistema permite la integración con el Sistema de Banco de Sangre existente en el establecimiento para la gestión toma de muestras por paciente. Datos demográficos de pacientes, Solicitudes de toma de muestras, Agendamiento, completitud de Formularios asociados a exámenes, como: • Formulario de envío de muestra para confirmación de VIH. • Formulario de envío de muestra para confirmación de VIH Pediátrico. • Formulario de envío de muestras para HTLV I/II. • Formulario de envío muestras clínicas. • Formulario general de envío de muestras clínicas para análisis Virológicos. • Formulario para confirmación serológica Enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi) Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre. • Registro en RCE de resultados e informes diagnósticos autorizados por el establecimiento.	Necesario	7		
UMT02	**Sistema de agenda y registro:** El Sistema permite: • Agendamiento de Toma de Muestras. • Registro de resultados de los distintos tipos de exámenes.	Exigible	N/A		
UMT03	**Integración con sistema de banco de sangre:** El sistema debe integrarse con el sistema informático de banco de sangre que se utiliza actualmente dentro de la Unidad y posteriores actualizaciones o cambio de este.	Exigible	N/A		
UMT04	**Visualización y registro en RCE:**	Exigible	N/A		

	El sistema debe permitir según rol autorizado al equipo profesional de la unidad, la visualización y registro de evolución clínica para aquellas prestaciones y atenciones realizadas en contexto de pacientes de urgencia, hospitalizado y ambulatorio.				
UMT05	**Agendamiento de donantes:** Recepción: El sistema debe permitir agendar a potenciales donantes en una lista de trabajo propia de la unidad, disponible en formato de agenda, visualizable por el equipo de la unidad según rol autorizado. El sistema debe permitir actualizar en el momento los datos demográficos y de contactabilidad del donante.	Exigible	N/A		
UMT06	**Módulo gestor de población donante del establecimiento:** El programa debe permitir el registro de citas de potenciales donantes y administración de su base de datos, para efectos de realizar una gestión de contactabilidad al usuario, con el fin de entregar información, agradecimientos y otros mensajes a la población donante activa.	Necesario	7		
UMT07	**Gestión y administración de solicitudes de procedimiento de trasfusión:** Sistema debe permitir la gestión de solicitud desde los distintos servicios clínicos, la solicitud de transfusión sanguínea debe tener un conjunto mínimo de datos que corresponde a: • Nombres y apellidos completos del receptor • RUN • Fecha de nacimiento • Procedencia • Nombre del hemoderivado y cantidad solicitada • Grado de urgencia de la transfusión (que se pueda mostrar por colores) • Diagnostico principal y comorbilidades • Motivo de transfusión • Parámetros hematológicos, dependiendo del hemocomponente solicitado.	Exigible	N/A		

	• Reacciones adversas anteriores a alguna transfusión • Fecha, nombre y firma del médico responsable de la transfusión. • Toma de muestras para pruebas de compatibilidad Respecto del conjunto mínimo de datos descrito anteriormente, el sistema debe tener la capacidad de enviarlo por mensajería bajo algún estándar de interoperabilidad al sistema vigente en la unidad de medicina transfusional.				
UMT08	**Visualización y registro en RCE:** El sistema debe permitir registro de transfusión con datos de re-control de grupo sanguíneo, fecha, producto, volumen total, responsable de instalación con hora de inicio, temperatura de transporte de hemoderivados, registro de reacciones adversas a la transfusión, hora de término y nombre de responsable del término, control de signos vitales pre y post transfusión. Siendo esta operación trazable y capaz de generar reporte estadístico por servicio o unidad clínica en distintos períodos de tiempo donde se realizó la actividad clínica.	Exigible	N/A		

9.2 Laboratorio Clínico

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Página oferta técnica
		Carácter	Puntaje		
LAB01	**Integración con LIS del Establecimiento:** Permite la integración con el LIS existente en el establecimiento y con sus próximas actualizaciones para la gestión de exámenes de laboratorio por paciente. Datos demográficos de pacientes, Solicitudes de exámenes, sugerencia de relevancia de agendamiento, completitud de Formularios asociados a exámenes, como: • Registros de solicitud de exámenes del laboratorio del	Exigible	N/A		

	hospital provincial de Ovalle que se encuentren validados en conjunto a notas de relevancia clínica que pueda agregar el profesional solicitante.				
LAB02	**Visualización de resultados/ Integración e interoperabilidad** El RCE disponible en la plataforma del HIS, debe permitir un vínculo al sistema de visualización de resultados de LIS disponible en el hospital, de manera de garantizar la disponibilidad de estos independiente del nivel de integración informático.	Exigible	N/A		
LAB03	**Gestor de solicitudes:** El Sistema permite para el caso solicitudes derivadas de atención ambulatoria un gestor de solicitudes de exámenes que permita: • Agendamiento de toma de muestras • Asignar cupos de agenda derivados desde el LIS para el proceso de toma de muestras • Debe permitir al medico generar un nivel de prioridad para los plazos en los cuales se debe realizar la toma de muestra, además de notas de relevancia clínica como indicaciones específicas para la toma de muestra (post ejercicio, día de ciclo menstrual, actividad de sueño, entre otros) • El gestor de solicitud debe mostrar los distintos estados de está, que pueden ser, por ejemplo: solicitado, agendado, atendido, en análisis completo u otro a definir en la implementación • Notificación de valores críticos por evento. Valor que debe quedar registrado en el RCE del HIS • Notificación de rechazo de la muestra • Obtención REM VIH/VDRL • Ingreso grupos de pesquisa	Necesario	7		
LAB04	**Integración con LIS del Establecimiento:**	Exigible	N/A		

	Debe permitir la integración con el software informático de laboratorio y sus actualizaciones o con el software que se implemente en un futuro. Los plazos para definir para futuras integraciones entre LIS y HIS deben ser aprobados y visados por el establecimiento.				
LAB05	**Integración con LIS del Establecimiento:** El sistema debe hacer llegar a bandeja de entrada o trabajo del sistema LIS, las solicitudes de exámenes derivadas desde la atención de pacientes hospitalizados y otros de atención cerrada como lo es hospitalización domiciliaria, servicio de urgencia.	Exigible	N/A		
LAB06	**Integración con LIS del Establecimiento:** Para el caso de atención cerrada, el sistema debe permitir generar etiqueta tipo térmica para rotulado de las muestras, con un conjunto mínimo de datos, que incluya datos de identificación de paciente como otros a definir en implementación.	Necesario	7		

9.3 Imagenología

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
IMG01	**Registro de atención:** Registro de indicaciones, el sistema debe permitir al Médico y otros profesionales según rol autorizado: Registrar y visualizar las notas clínicas, en orden cronológico y/o separado por filtros según necesidad, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente, durante su permanencia en la sala de atención, en donde se realizaron los procedimientos acordes a las indicaciones entregadas. Para las indicaciones ejecutadas, se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo, además, vincularlo a la orden correspondiente.	Exigible	N/A		
IMG02	**Gestor de solicitudes de exámenes:** El sistema debe permitir envío y recepción de solicitudes de exámenes imagenológicos indicando procedencia de la	Necesario	7		

	solicitud, dando prioridad al paciente dependiendo del lugar de procedencia, bajo los criterios normados por la unidad de Imagenología. El sistema debe mostrar en formato digital electrónico el formulario de solicitud, permitiendo la firma digital del profesional solicitante.				
IMG03	**Requerimiento de prestaciones:** El sistema debe tener integrado el listado de prestaciones de imagenología según código y glosa de FONASA en tipología de modalidad de atención institucional MAI, vigente del año en curso y sus futuras actualizaciones.	Exigible	N/A		
IMG04	**Visualización de imágenes e Integración CON RIS-PACS:** El sistema permite la integración con el sistema RIS-PACS para la visualización de los registros de exámenes e imágenes que se han realizados o están a la espera dentro de RIS-PACS.	Necesario	7		
IMG05	**Gestión de agendamiento:** El sistema permite agendar un examen por un profesional o un recurso (equipo clínico) ejemplo: Ecógrafo.	Necesario	4		
IMG06	**Integración con RIS:** El sistema debe permitir la integración con el RIS actual y futuras versiones del establecimiento para la gestión de exámenes de imagenología por paciente. Datos demográficos de pacientes, solicitudes de exámenes, agendamiento, registro en RCE de las imágenes e informes. El oferente debe declarar y detallar la integración como se desarrolla y a qué nivel está lograda.	Exigible	N/A		
IMG07	**Alerta Clínica:** Función de alarma cuando paciente tenga antecedentes de reacción al medio de contraste y extravasación. La alerta una vez registrada debe ser visible cada vez que se consulten los datos del paciente.	Necesario	4		
IMG08	**Toma de Exámenes:** Generación de indicaciones imprimibles para el paciente para cada prestación previa a la realización del examen y posterior a este (radiografías simples, radiografías complejas, tomografías, mamografías y ecografías y otras prestaciones según determine el establecimiento).	Necesario	4		
IMG09	**Registro de resultados:** El sistema debe permitir gestión de alerta ante resultado crítico en	Necesario	2		

	informe, para notificación al usuario.				
IMG10	**Sistema de gestión de solicitudes:** El sistema debe permitir el envío de ordenes de exámenes que no se encuentran en cartera de servicio de imagenología a plataforma de aprobación para aquellos exámenes asociados a compra de servicio.	Necesario	4		

9.4 Hemodiálisis

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
HDL01	**Registro de atención/Registro de indicaciones:** El sistema debe permitir al equipo multidisciplinario registrar las notas clínicas, en orden cronológico y/o separado por filtros según necesidad, de acuerdo con el acto realizado en los diferentes contactos con el paciente, durante su permanencia en la sala de atención o de observación, en donde se realizaron los procedimientos acordes a las indicaciones entregadas. Para las indicaciones ejecutadas, se debe permitir el registro de un conjunto de datos específicos según tipo, además, vincularlo a la orden correspondiente. • Debe estar vinculado a la agenda y cita, de tipo multiprofesional. • Registro de pautas de sesiones de Hemodiálisis y peritoneo diálisis de acuerdo con normas, siendo identificadas únicamente y asociada a sus parámetros para seguimiento. • Registro de sesiones con acceso fácil a los antecedentes del paciente para lectura y modificación, ya sean diagnósticos, exámenes de laboratorio, alergias y alertas, vacunas, historia de sesiones anteriores, acceso vascular, indicaciones.	Necesario	7		

	• Acceso a la ficha única y trasversal del paciente. • Debe permitir generar solicitudes de pruebas de todas las carteras de prestación del establecimiento. • Debe permitir solicitud y administración de hemoderivados y sus exámenes específicos. • Debe tener evolución diaria, resumen mensual nefrológica, tanto médicas, de Enfermería y otros profesionales. • Registro de incidencias de pacientes según tipos de categoría, como ingresos a centro hospitalario, registro de transfusiones, registro hospitalizaciones en otros establecimientos, vacunaciones externas, entre otras.				
HDL02	**Dispensación de insumos:** Debe permitir crear pack, de insumos y fármacos con su gestión por sistema. Con el objetivo de mantener actualizado el stock asignado a la unidad.	Necesario	4		
HDL03	**Responsividad y uso de TABLET:** Posibilidad que, a través de las características responsivas del diseño de software, registrar y monitorear formularios e indicaciones asociadas a la atención clínica de diálisis según rol autorizado, a través de un dispositivo como una Tablet de características tipo Android e IOS compatible	Necesario	4		

9.5 Anatomía Patológica

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
APA01	**Integración con sistema de anatomía patológica:** El sistema debe permitir la integración con el sistema utilizado actualmente en la Unidad de Anatomía Patológica o un nuevo sistema que el establecimiento utilice.	Exigible	N/A		

APA02	**Integración con sistema de anatomía patológica:** El sistema debe mostrar a través de integración con el software de anatomía patológica, la gestión de ingreso, proceso y resultados de biopsias en el RCE.	Necesario	4		
APA03	**Seguimiento de proceso:** El sistema debe permitir el seguimiento de procesamiento clínico de las muestras con fecha/ hora de cada orden de examen, orden de examen posterior a la orden inicial, ejecutada por profesional.	Necesario	4		
APA04	**Seguimiento de proceso:** El sistema debe permitir el seguimiento de proceso solicitado con fecha/ hora y el profesional que recibe la muestra. Así como también cuando el resultado es recepcionado en la unidad de archivo clínico.	Necesario	4		
APA05	**Alerta informe pendiente:** El sistema debe permitir generar una alerta de que el paciente tiene pendiente una hora para informe de resultado de examen que no ha sido agendado.	Necesario	4		

9.6 Nutrición y Dietética

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
NYD01	**Registro de atención:** Para el registro de indicaciones el sistema debe permitir al nutricionista registrar notas clínicas en orden cronológico y/o separado por filtros según necesidad, de acuerdo con la atención clínica realizada al paciente Para las acciones clínicas derivadas de una indicación médica, se debe permitir el registro de estas manteniendo su trazabilidad y cambio de estado (pendiente/realizado).	Exigible	N/A		
NYD02	**Registro de indicaciones:** Debe permitir registrar indicaciones de fortificación de leche materna y preparación de otras fórmulas lácteas. También la indicación de nutrición enteral y suplementos a pacientes en	Necesario	4		

	servicio de hospitalización y unidades de emergencias.				
NYD03	**Gestor de prescripciones dieto terapéuticas** Debe permitir distintas prescripciones dieto-terapéuticas, como consecuencias de una indicación médica ejecutada por el nutricionista dentro de un plazo de 24 horas, por ejemplo, realimentación post operatoria, ayuno transitorio por examen, siendo estas visualizables para el equipo clínico.	Necesario	4		
NYD04	**Gestor de prescripciones:** Prescribir alimentación láctea artificial y alimentación enteral (SEDILE/CEFE). Debe considerar manejo de diferentes tipos de fórmulas lácteas, formulas especiales. cambios frecuentes de indicaciones, diferentes volúmenes, incorporación de nutrientes, módulos lipídico, proteico y calórico, cálculo de producción. Quedando registro del destino de las preparaciones por distintas unidades, servicios y otras unidades de responsabilidad del hospital.	Necesario	7		
NYD05	**Registro de atención:** Permitir el registro de control de ingesta, eventos adversos y otras observaciones generales, así como, el seguimiento nutricional del paciente.	Exigible	N/A		
NYD06	**Registro de atención:** Debe incluir funcionalidad de registro de evaluación nutricional según tipo de paciente (a lo largo del ciclo vital) y su norma de evaluación vigente según MINSAL. Por ejemplo: Patrones de crecimiento para evaluación nutricional de niños, niñas y adolescentes, desde el nacimiento hasta los 19 años, y otras normas vigentes.	Necesario	7		
NYD07	**Consolidación de indicaciones por servicio clínico:** Se debe considerar un consolidado final de la solicitud de cada servicio clínico, tipo de dietoterapia e indicaciones específicas de cada paciente, información necesaria para entregar correctamente la indicación al paciente por parte del funcionario encargado.	Necesario	4		
NYD08	**Gestor de prescripciones:**	Exigible	N/A		

	Permitir validaciones y/o modificaciones a la prescripción según perfiles, por ejemplo, ajuste de la dieta realizada por nutricionista.				
NYD09	**Registro de atención:** El sistema debe permitir tener disponible todas las pautas y/o indicaciones de alta para todos los regímenes estandarizados y cargados al sistema.	Necesario	4		
NYD10	**Consolidación de indicaciones por servicio clínico:** Consolidar indicación dietética con la siguiente estructura: · Nombre de paciente · Edad · Indicación de régimen · Especificación de ajuste de molécula calórica distribuida en 4 tiempo de alimentación y presencia o no de tiempos de colación, detalle según vía de administración (enteral, parenteral o mixta). · indicación de líquidos de hidratación. · Diagnóstico Clínico . Diagnostico Nutricional · Observaciones	Necesario	7		
NYD 11	**Registro de informe/resumen de atención nutricional:** El sistema debe permitir al equipo clínico según rol autorizado imprimir para la entrega al paciente y acompañante: • Informe resumen de la atención nutricional hospitalaria. • Grafica de Evaluación nutricional y su evolución • Educaciones, indicaciones y recomendaciones nutricionales al alta.	Necesario	4		

9.7 Unidad de Procedimientos Ambulatorios

N°	Funcionalidades	Tipo de exigencia		Cumple (si/no)	Documento Nro. de página
		Carácter	Puntaje		
UPA01	**Visualización de tabla de pabellón cirugía menor:** Permite visualizar tabla operatoria por especialidad, listado que incluya nombre, edad, RUN, diagnóstico, procedimiento o intervención quirúrgica a realizar, equipo quirúrgico, insumos requeridos e instrumental, unidad de origen y destino, tiempo quirúrgico estimado.	Necesario	4		
UPA02	**Registro de agenda de paciente:** Permitir alertar la llegada del paciente dentro de las agendas correspondientes a recursos y profesionales, y registrarla en el sistema.	Necesario	4		
UPA03	**En etapa de preparación previa:** Permitir registrar entrevista con enfermería, para antecedentes mórbidos quirúrgicos, alergias, medicamentos de uso habitual y hábitos.	Necesario	4		
UPA04	**Manejo de formularios:** Permitir la parametrización, configuración y posterior habilitación para el registro de formularios y documentos de uso frecuente en la unidad como: • Check list de cirugía menor • Hoja de monitorización de pacientes sometidos a procedimientos ambulatorios • Otros, según requerimientos de la unidad y establecimiento.	Necesario	7		
UPA05	**Visualización de mapa de piso:** Permite mostrar de manera gráfica el mapa de piso de la unidad, con sus camillas y sillones, como también permitir visualización de procedimientos asociados y/o agendados al paciente. Se deben mostrar los siguientes datos: nombre del paciente, RUN, edad, tiempo de estadía, así también los estados de la camilla o sillón (ocupado, disponible, reservada, en mantención, entre otros).	Exigible	N/A		
UPA06	**Visualización de lista de trabajo:**	Necesario	4		

	El sistema debe alertar en lista de trabajo, las solicitudes de procedimientos que se realizan en la unidad, definiendo el origen de las solicitudes. El sistema debe permitir seleccionar la priorización de las solicitudes.				
UPA07	**Registro de agenda de paciente:** El sistema debe permitir realizar la gestión del agendamiento de distintos procedimientos asociadas a las especialidades que se desempeñan dentro de la unidad. El agendamiento debe considerar el procedimiento, la prestación con los códigos MAI Fonasa vigente del año en curso correspondientes a las siguientes especialidades: • Cardiología. • Broncopulmonar. • Urología Indiferenciado. • Cirugía Buco Maxilofacial. • Cirugía Menor. • Gastroenterología. Otras especialidades que el establecimiento determine para su cartera de servicios.	Exigible	N/A		
UPA08	**Registro de informe:** Permitir al equipo clínico según rol autorizado las siguientes funciones: Se debe permitir el registro del informe con diagnóstico, el procedimiento realizado y permitir su impresión para la entrega al paciente y su acompañante. Se debe permitir imprimir hoja de indicaciones para el paciente. profesional (s) Responsable. Exigible por estándar de acreditación la entrega de informes de procedimientos diagnósticos y terapéuticos ambulatorios y de cirugía mayor ambulatoria.	Exigible	N/A		
UPA09	**Recetas:** El sistema debe permitir al rol autorizado la prescripción de medicamentos utilizados en cada procedimiento.	Exigible	N/A		
UPA10	**Insumos:** El sistema debe permitir al rol autorizado la indicación de insumos utilizados en cada procedimiento.	Exigible	N/A		
UPA11	**Reporteria de producción de la Unidad:** El sistema debe generar reporte de procedimientos realizados en la unidad, en rangos de fechas	Necesario	4		

	variables, con campos a definir por la unidad. El reporte debe ser exportable en formato PDF, o en formato homologable a Microsoft office.				

NUMERO DE FUNCIONALIDADES FORMULARIO 5	
Total Funcionalidades	509
F. EXIGIBLES	259
F. NECESARIOS	250

NOTA 1:
Para efectos de la asignación de puntaje durante la evaluación de las ofertas, se deberá considerar la categorización y puntaje asignado a los distintos tipos de funcionalidades necesarias según la siguiente tabla.

Tabla de complejidad y puntaje de las funcionalidades necesarias			
Funcionalidad	**Puntaje (cada Una)**	**cantidad**	**Puntaje máximo**
Necesaria de baja Complejidad	2	15	30 ptos
Necesaria de Mediana Complejidad	4	89	352 ptos
Necesaria de Alta Complejidad	7	146	1022 ptos
Puntaje Final del criterio de Evaluación			1408 ptos

NOTA 2:
Tratándose de las funcionalidades necesarias categorizadas de mediana y alta complejidad, no aplica la obligatoriedad de indicar archivo y numero de página.